

韓國醫療

目錄

韓國醫院體系	3
醫院分級.....	4
JCI 認證醫院	5
JCI 認證標準.....	5
醫院類型、人口分布以及院所分布.....	6
醫師比率.....	10
醫藥分離制度	12
醫療法.....	13
電子病歷管理和保存所需設施、設備標準.....	13
推動提高醫務社工安置標準.....	14
《通過半遠程醫療法案，請阻止總統》	15
《南韓衛福部呼籲遠距醫療制度化》	15
醫療法修正案	16
患者選擇醫生	17
手術室閉路電視設置法醫療法修正案施行日期	18
老人親和產業支援法(高齡友善產業振興法)	20
高齡友善產業發展計劃	21
醫療保險	21
國民健康保險法	21
醫療援助計畫	23
長期護理保險計畫.....	23
遇到困難.....	24
韓國國際醫療協會(CKMP).....	24
介紹	24
推動觀光醫療計畫.....	25
自由貿易經濟區	29
智慧醫療	31
韓國智能家居醫療保健服務.....	31
智慧醫療.....	33
智慧醫院.....	37

台韓比較.....	47
健保.....	47
傳統醫學.....	49
醫療旅遊.....	51
智慧醫療.....	51
人口與院所分布	52
醫院分級.....	53
醫藥分業.....	54
台灣加工區、自由貿易經濟區與韓國自由貿易區	55
長期照顧.....	55
遠距醫療(通訊醫療)法案	62
總結韓國優勢	64
結論.....	64
參考資料.....	66

韓國醫院體系

韓國平均每 1000 人中擁有 10 張病床，遠高於經合組織國家平均 1000 人 5 張的水平。根據 Mark Britnell 的說法，醫院在衛生系統中占主導地位。韓國的醫院有 94% 為私人所有，例如韓國三星首爾醫院，其中 43 家三級醫院中就有 30 家由私立大學經營，還有 10 所由公立大學經營。付款方式是按服務收費的，政府對醫院沒有直接補貼。這鼓勵了醫院的擴大，但是阻礙了社區服務。

在韓國幾乎所有的醫療衛生服務都有私營醫療機構提供，私營醫療機構占據了 88% 的病床、91% 的醫療專家、90% 的門診服務，以及 93% 的急診救護。

韓國的醫療保健滿意度一直位居世界前列，韓國醫療保健系統被彭博社評為第二高效的醫療保健系統。其醫療保健系統基於國民健康保險服務，是由衛生和福利部運營的公共健康保險計劃，有足夠收入的韓國人必須向政府繳納自己及其家屬的保險費。另有醫療援助計劃，是由中央政府和地方政府共同實施的一項社會福

利計劃，主要是為那些無法繳納國民健康保險費的人提供保險。

健保制度在後面也會有所提及。

參考資料:

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E4%BD%93%E7%B3%BB>

<https://www.publichealth.columbia.edu/research/others/comparative-health-policy-library/south-korea-summary>

2012 年台灣醫療服務國際化韓國考察團(需下載)

醫院分級

醫院的分級有分為一級、二級、三級。

一級	二級	三級
當地診所	醫院、綜合醫院	整體護理的綜合醫院
輕微疾病的患者可以使 用當地診所	病症較嚴重	

診所:擁有 29 張病床的醫療機構。

醫院:擁有 30 張或以上床位的醫療機構。

綜合醫院:有 100 張或以上病床的醫療機構。擁有 100 至 300 張床位的綜合醫院必須有至少 7 個醫療科室，除了有內科、外科、兒科、婦產科中任意 3 科，還要包括放射科、麻醉和止痛藥科、健康篩檢或病理科，並且各科室必須要有專家。擁有 300 張床位以上的綜合醫院需要有 9 個醫療科室，除了各科室本身所需的醫療專科，還包括牙科和精神科。綜合醫院都必須配備治療嚴重疾病患者所需的人力和其他物力。除非緊急情況發生，只有那些獲得診所或醫院醫生轉診通知的患者方能入院接受治療。急救醫療機構分為中央、區域、專門、地方、地方分急救醫療機構。在韓國，共有 455 支緊急醫療中心。

韓國病人可以選擇任何醫生或者醫療機構或醫院，推薦安排系統分為兩個步驟，病人可以去任何辦公室，但除了專門的綜合醫院。如果病人想要去二級醫院，他必須出示轉診單，但在分娩、緊急醫療護理、牙科護理、康復、家庭醫學服務和

血友病的情況下，患者可以在沒有轉診單的情況下去任何醫院。

參考資料: 2012 年台灣醫療服務國際化韓國考察團(需下載)

JCI 認證醫院

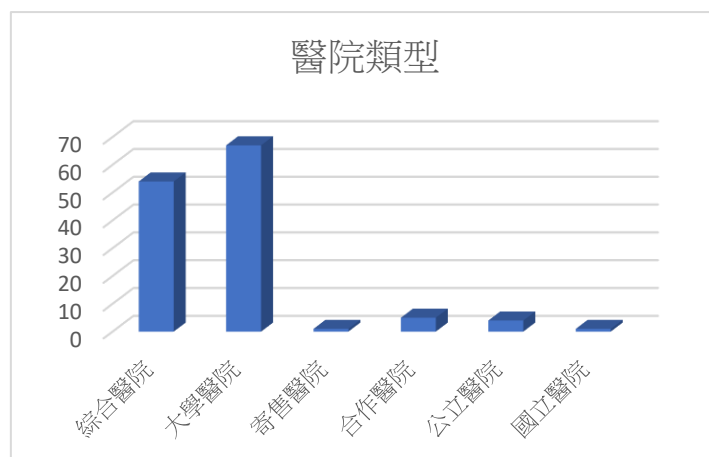
在韓國共有 33 所醫院被 JCI 認證。其中特別列出 7 所:

Goodwill Dental Clinic at Hadan(韓國釜山)、Humphreys Dental Clinic、Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic、Korea University Anam Hospital 南韓高麗大學附屬醫學中心 Anam 醫院、Proud Urology Clinic、Severance Hospital(延世大學 新村世福蘭斯醫院), Yonsei University College of Medicine(延世大學 醫學院)、The Catholic University of Korea(韓國天主教大學), Seoul St. Mary's Hospital(首爾韓國天主教大學首爾聖瑪麗醫院)

參考資料: <https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending>

JCI 認證標準

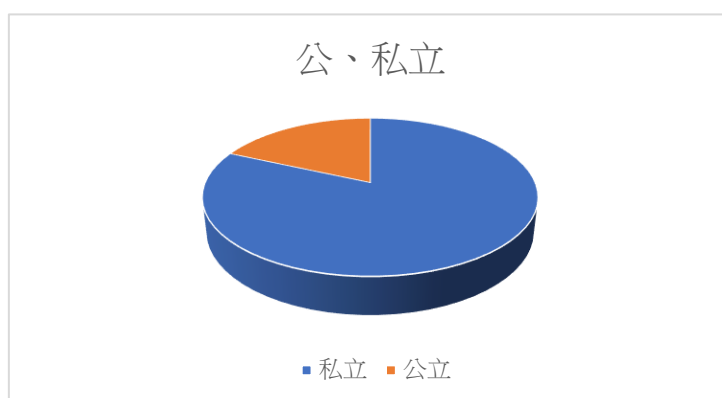
International Patient Safety Goals (IPSG)	國際患者安全目標 (IPSG)
Access to Care and Continuity of Care (ACC)	獲得護理和護理連續性 (ACC)
Patient and Family Rights (PFR)	患者和家庭權利 (PFR)
Assessment of Patients (AOP)	患者評估 (AOP)
Care of Patients (COP)	患者護理 (COP)
Anesthesia and Surgical Care (ASC)	麻醉和手術護理 (ASC)
Medication Management and Use (MMU)	藥物管理和使用 (MMU)
Patient and Family Education (PFE)	患者和家庭教育 (PFE)
Quality Improvement and Patient Safety (QPS)	質量改進和患者安全 (QPS)
Prevention and Control of Infections (PCI)	感染預防和控制 (PCI)
Governance, Leadership, and Direction (GLD)	治理、領導力和方向 (GLD)



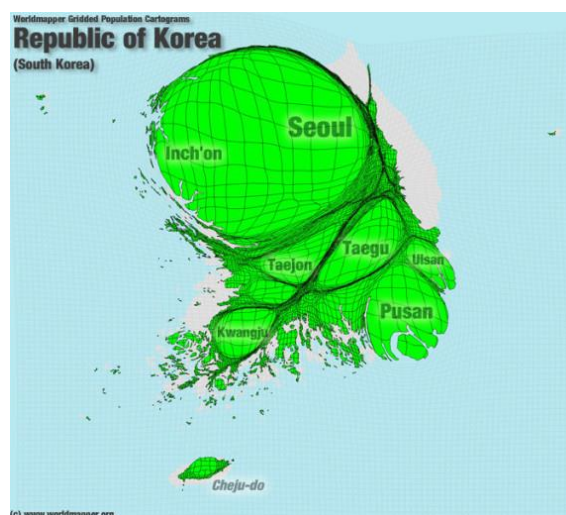
以附件 1 來看韓國醫院類型，韓國醫院以大學醫院為最多，第二多為綜合醫院，公立醫院有兩間，國立醫院則只有一間。

公、私立醫院

以附件 1 來看的話，因為只有部分的醫院有填寫公立或者私立，單獨以有填寫的醫院去比較，私立醫院比公立醫院還要多。



人口分布



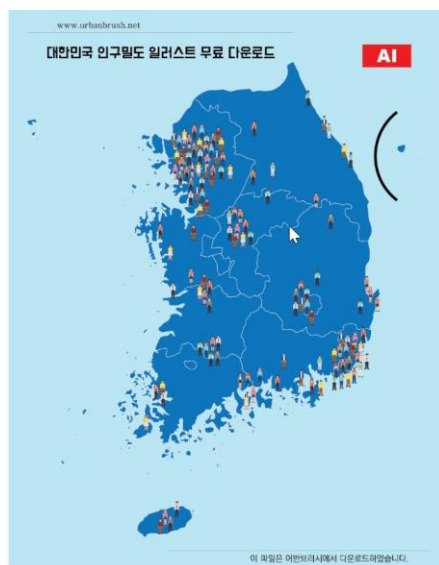


圖: <https://www.urbanbrush.net/zh-TW/%E4%B8%8B%E8%BC%89/%E9%9F%93%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%88%86%E4%BD%88%E5%9C%96%E5%85%8D%E8%B2%BB%E4%B8%8B%E8%BC%89/>
<https://blog.naver.com/lofsism/60093159607>

韓國人口排名(2023/1/15)			
1. 京畿道 13,589,432 人 23.42%	2. 首爾特別市 9,428,372 人 18.33%	3. 釜山廣域市 3,317,812 人 6.45%	4. 慶尚南道 3,280,493 人 6.38%
5. 仁川廣域市 2,967,314 人 5.77%	6. 慶尚北道 上 2,600,492 人 5.06%	7. 大邱廣域市 2,363,691 人 4.6%	8. 忠清南道 2,123,037 人 4.13%
9. 全羅南道 1,817,697 人 3.53%	10. 全羅北道 1,769,607 人 3.44%	11. 忠清北道 1,595,058 人 3.10%	12. 江原道 1,536,498 人 2.99%
13. 大田廣市 1,446,072 人 2.81%	14. 光州廣域市 1,431,050 人 2.78%	15. 蔚山廣域市 1,110,663 人 2.16%	16. 濟州特別自治道 678,159 人 1.32%
17. 世宗特別自治市 383,591 人 0.75%			

醫院分布

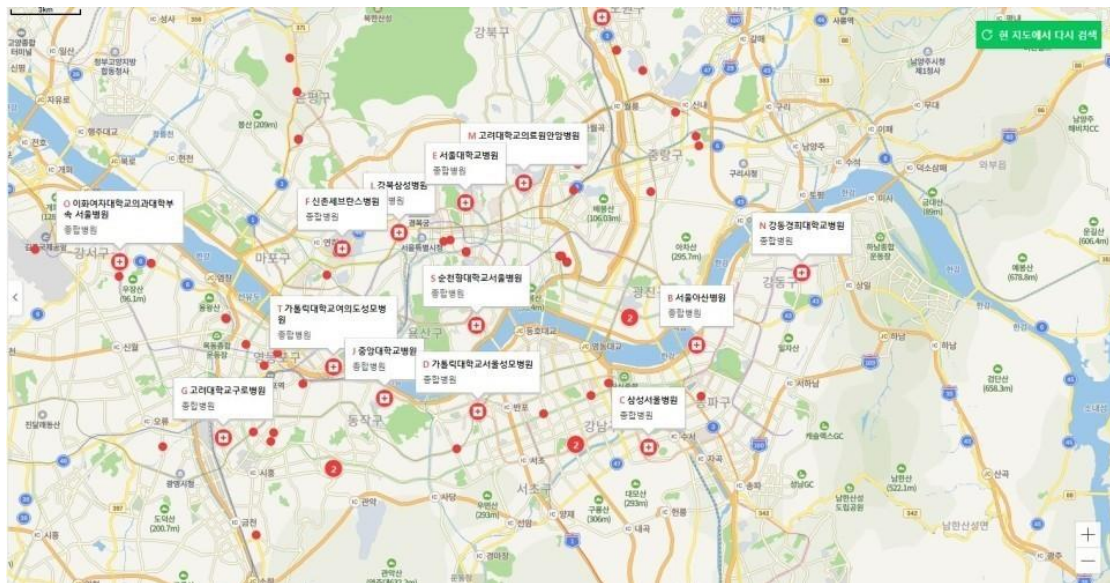


京畿道大型醫院分布圖

圖:

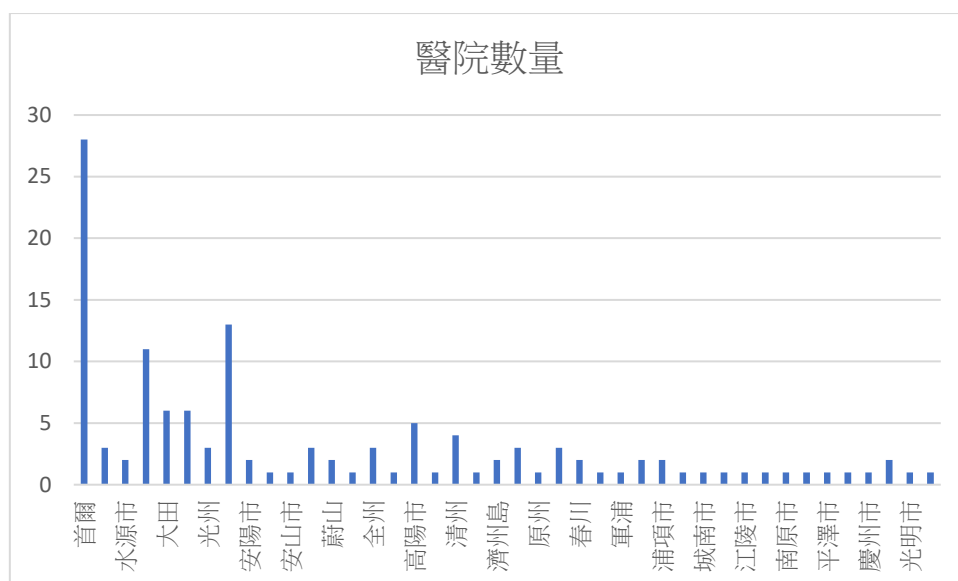
<https://cafe.naver.com/arccommunity/2000?art=ZXh0ZXJuYWwtc2VydmliZS1uYXZlci1zZWYyY2gtY2FmZS1wcmg.eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpvcXVCJ9.eyJyZWZlVHlwZSI6ImNBRkVfVGVJMIiwiaWF0Ij00OTk2NjY5LjgzZS1dhaGCoDB3ruirNZajzKfn4W-0gp9W8MUio4c>

首爾大學醫院分布



各市醫院數量

以附件 1 來看首爾醫院有 28 間，釜山有 13 間，則仁川有 11 間，大田及大邱則有 6 間、高楊市有 5 間，韓國醫院主要都在城中地區，其餘地區都市 1 到 4 間不等，基本上都為 1、2 間。



韓國地圖

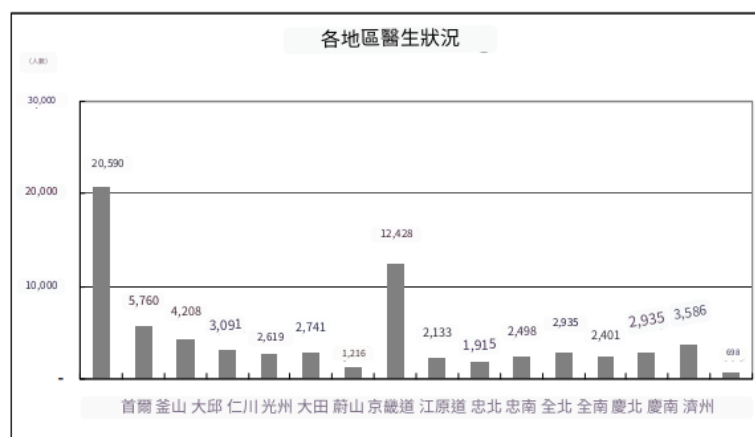


醫師比率

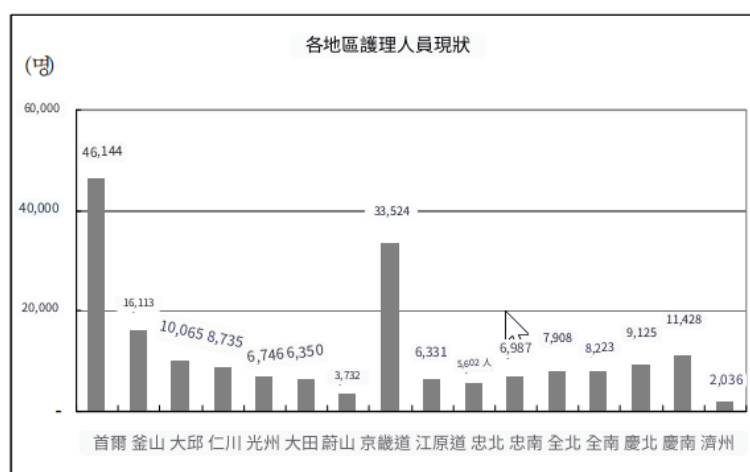
截至 2006 年 6 月末，縱觀韓國的衛生和醫療人員情況，共有 71,754 名普通醫生（包括專科醫生）、18,654 名牙醫、東方醫生人數為 13,311 人，護士人數為 93,989 人，護理助理人數為 13,311 人。藥師方面，醫院藥師 3,103 人，藥房藥師 27,903 人。就醫療技術人員職位而言，14,937 名臨床病理學家、13,929 名

放射技師和物理治療師、醫務人員 16,897 人、職業治療師 679 人、牙科技師 2,063 人、牙科保健員 16,914 人，2,797 台醫療記錄儀。從分佈來看，每 10 萬人中的衛生保健人員有 148.6 名醫生、38.6 名牙醫、27.6 名東方醫生、護士和護理助理分別為 194.6 和 196.8。從衛生人員分佈情況看，地區間衛生人員分佈不平衡。就活躍在大城市地區的醫生而言，蔚山和仁川，他們分別為 113.2 和 119.1，遠低於平均水平 148.6，而首爾這個 205.5，與大城市之間存在 1.8 倍的差異。從地區來看，除了全北地區（163.4 人）以外，其他地區都低於平均水平。

[圖IV-1]各地區醫生現狀



[圖IV-2]各地區護理人員現狀



首爾每人口中醫生、牙醫、韓方醫生、藥劑師和放射科醫生的比例是最高的。釜山人均護理助理比例最高，大田的人均牙科技師和醫療記錄員的比例最高。

它發生了光州的護士、化驗員、牙科保健員的比例最高。就物理治療師而言，全羅南道地區的比例最高。

醫藥分離制度

參考資料: https://www.taiwan-pharma.org.tw/association/magazine_download.php?vol=128&file=004.pdf

基本原則

- (一) 醫藥分業施行方案之促進係以現行法規為基礎。
- (二) 醫藥分業為醫、藥界之間各司其職，並以減少全體國民負擔與不便為促進方向。

施行方向細則

(一)除注射劑之外，所有處方藥品皆為醫藥分業之品項。(二)診所對於門診病人須義務釋出處方箋。但設有調劑室的醫院級醫療機構，可以開立院內、外皆可使用之處方箋，由病人自行選擇在醫院內或至藥局配藥。(三)處方箋上記載之藥品，可用一般名稱或商品名稱。但若以商品名稱記載，且標示有「不可取代」字樣時，可以使用具生體相等性藥品 (BE) 並經福祉部公告之藥品來代換。除此之外的藥品，皆須經醫師同意後才可更換。(四)為便利民眾用藥，地區內醫藥分業協議組織可在事前將商品名稱用藥清單通報予當地藥局。然而此一共識雖然形成，但基層人員對於施行方向細則，卻有不同的意見，更提出許多執行面的問題，包括：注射劑是否應納入醫藥分業的品項？施行對象是否應涵蓋所有診所及醫院的門診病人？處方箋開立形式？藥局要如何備貨庫存？是否要重新檢視處方藥與指示藥的分類？於是醫藥分業促進委員會在第4次會議決議事項中，將各界提出之意見，分別以醫師協會、醫院協會與藥師公會之名義，向國會提出醫藥分業施行延期之請願 (1998.11-12 月) --醫藥分業制度實施再次延期。

相關配套措施同步進行

隨著醫藥分業，很重要的一環就是醫療保險給付制度的統合。在醫藥分業之前，韓國藥品費用在醫療費用中佔有很高的比例。醫生既有處方權，又有藥品銷售權，即醫院、診所都有自己的藥局可以賣藥。同時，消費者不用處方也可以直接從藥局購買藥品，醫師與藥師間的職責不分。在藥品銷售中，平均有 50% 的差價收入，受經濟利益的驅動，醫師和藥師多開藥、多賣藥，收入就增加 4 倍，致使缺乏對所開處方正確性的審核監督機制 (Check and Balance)，過度利用或濫用藥物的情況十分普遍。1989 年 7 月韓國政府實施全民健康保險制度，調高醫療服務費；1999 年針對健保藥品實施以實際交易價格作為調整藥價基準制度 (Actual Transaction Price Reimbursement Policy)，以期降低藥價差，促使整體健保藥價給付下降 30.7%；對於民眾的便利性也有考量到，同步推動家庭醫師/家庭藥師制度、實施保健所之夜間診療等措施，讓民眾得到完整的照護。

醫療法

電子病歷管理和保存所需設施、設備標準

一、「電子病歷」是指將醫務人員製作的病歷等病歷資料錄入、管理、存儲為帶有電子簽名的電子文檔的記錄。

二、「電子病歷系統」是指與電子病歷管理和保存相關的服務器、軟件和數據庫以電子方式組織的系統。

三、「電子病歷管理人」是指管理電子病歷系統的醫務人員或者醫療機構創建者。這種情況下，根據《個人信息保護法》第 26 條的規定，包括受醫務人員或醫療機構創辦人委託處理個人信息的電子病歷系統的管理人員。

四、「日誌信息」是指服務器或計算機在處理或使用過程中隨時間以電子方式記錄的信息。

五、(電子病歷生成、存儲等設備)電子病歷管理人員應當配備能夠生成、存儲電子病歷和驗證電子簽名的設備，保障電子病歷的安全、可靠。

六、(電子病歷管理所需設備)電子病歷管理人員可以讓電子病歷管理人員檢查電子病歷是否有新增錄入、修改情況以及變更後是否發生變更。電子簽名已簽署。您必須擁有為此所需的設備。

七、(電子病歷備份存儲設備)電子病歷管理人員按下列類別保管設備和場所，以防電子病歷丟失、被盜、洩露、偽造、篡改、損壞等事故發生。

1.具有定期安全備份電子病歷功能的備份存儲設備

2、存儲區設有備用存儲設備的鎖定裝置

八、(與網絡、電子病歷系統安全相關的設施、設備等)醫療法根據《施行細則》(以下簡稱《細則》)，第十六條第一項第四款至第六款規定的設施、設備，應依照《個人信息保護法》第二十九條規定採取安全措施。在這種情況下，各設施和設備的具體措施應符合以下規定。

九、（醫療機構以外場所的附加管理和保護措施）設備必須按照附表採取附加措施。

推動提高醫務社工安置標準

收錄自韓國新聞：

<http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3000892>

2022.02.22

厚生省正在推動通過醫療機構的醫療社會工作者發現危機家庭並建立收費制度的同時，在野黨也提出了相關法案。此外，民主黨議員南仁順 22 日宣布，已提出「醫療法修改法案」，將提高醫療社會工作者的安置標準。

醫務社工是指依照醫療服務法施行細則，指派到綜合醫院的一名或多名社會工作者，目前全國共派駐到綜合醫院的社會工作者共有 988 人。取得一級社會工作者資格後，在醫院級醫療機構完成至少一年的培訓課程後，即可獲得醫療社會工作者資格。修正案明確了法律依據，提高了《醫療法施行細則》規定的醫療社會工作者的安置標準。綜合醫院及衛生福利部條例規定規模以上醫院級醫療機構，必須配備醫務社會工作者。其人員編制由衛生福利部令規定。特別是對強制派遣醫務社工的醫療機構，規定可給予全部或部分費用補貼。

南議員表示：「去年 8 月，因生活困難而結束生命的水原母女三人，因患有嚴重罕見疾病而被送往醫院，但眾所周知，她們被置於福利盲區。建議需要一名福利工作者。」南議員表示，根據現行醫療執法規定，綜合醫院必須至少配備一名社工，但 18% 的醫療機構沒有一名社工，每人負責的病人數量高達 813 人。這需要提供，南議員解釋了該法案的目的，「通過這項修正案，我們試圖減少醫療領域的福利盲點。」

與此同時，11 月 24 日，衛生福利部聯合公佈了《發現福利盲點完善支持體系的措施》，其中包括推進精準風險戶發現體系。具體來說，衛生福利部計劃發展醫療保險，通過醫院醫生、醫療社會工作者和地方政府之間的聯繫，使健康狀況惡化的危機家庭能夠獲得治療等支持並重返社區。

《通過半遠程醫療法案，請阻止總統》

收錄自韓國新聞: <https://www.hankyung.com/politics/article/2023031485761>

2023.03.14

非面對面治療平台，呼籲給總裁寫一封手寫信。「80%的行業面臨除初檢外只允許複檢的危機」

「總統先生，非面對面治療有結束的危險。衛生福利部表示將把它制度化，以便只有返回的患者才能使用它。懇請大家看一下三年來已實施 3500 萬例的非面對面治療，以便今後所有公民從第一次就診開始就可以使用，無需任何系統差距。」

9 日，非面對面治療平台 “Dr.Now” 聯合創始人樸建泰（27 歲）向龍山總統府遞交了包含這些內容的手寫信。Park 是一名開發商和年輕企業家，他於 2019 年從自己就讀的大學休學，並加入成為 Dr. Now 的創始成員。

樸先生在一封手寫信中表示，「當總統還是候選人時，非面對面的待遇是不可避免的現實，必須接受。我記得他說『我們將確保所有公民都能享受到尖端技術的好處』時感到自豪和鼓舞。朴槿惠之所以給尹錫烈總統寫信，是出於一種危機感，認為政府將非面對面治療制度化的方向根本沒有反映平台行業的聲音。本月早些時候，厚生勞動省制定了一項政策，允許對普通患者進行非面對面治療，從第二次就診開始，而不是第一次就診。非面對面治療平台公司擔心，如果該法律照此頒布，80%的相關公司將破產。遠程醫療產業協議會主席張智浩表示，「99%的非面對面治療應用程序用戶都是初治感冒等輕微症狀的患者。」我們將面臨危機。朝野提出的三項非面對面治療法（醫療法修訂案）均包含僅限慢性病患者等重複患者的內容。

《南韓衛福部呼籲遠距醫療制度化》

參考資料: [https://ibmi.taiwan-](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/zh/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0rrsov5akxo3816m)

[healthcare.org/zh/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0rrsov5akxo3816m](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/zh/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0rrsov5akxo3816m)

南韓衛福部公布了一項在 COVID-19 實施遠距醫療的一項報告。報告指出，從 2020 年 2 月到 2023 年 1 月，超過 25000 家醫療院所為 1379 萬人提供了遠距醫療，診療次數達 3661 萬次，大多數(2925 萬次)是針對 COVID-19 病立的居家通訊診

療，大約 136 萬個病例是首次就診，514 萬個病例在就診後獲得處方。

報告指出，大多遠距醫療是由社區診所進行的(占有參與醫療院所的 93.6%，占有診療紀錄的 86.2%)。南韓衛福部指出，大型醫院過去曾表示擔心會承擔大部分的遠距醫療需求，但實情並非如此。報告還發現，銀髮族和慢性病患者對遠距醫療的接受度很高。約有 288 萬次治療是提供給 60 歲及以上的族群。診療主要是針對高血壓、急性支氣管炎和糖尿病。

此外，在 2020 年臨時性的實施遠距醫療後，慢性病患對處方藥的依從性增加了。衛福部表示：「透過報告，我們證實非面對面的治療在一定程度上有助於改善健康狀況，例如改善年長者照顧方面的連續性。」南韓政府在 2020 年 2 月暫時允許實施遠距醫療，以限制 COVID-19 的傳播。取得正面的結果後，衛福部現在呼籲透過修訂《醫療服務法》相關條款使遠距醫療制度化。同時政府最近也接受韓國醫學會的建議，將遠距醫療作為實體看診的永久性輔助措施。衛福部還分享國家健保機關在 2020 年的調查結果，大多數透過電話接受處方的病患表示他們願意在未來再次使用這項服務。免於感染傳染病和減少等待的時間被認為是願意繼續使用遠距醫療的原因。韓國健康產業研究發展所在 10 月做的一項類似滿意度調查也指出，民眾願意通過通訊方式取得處方藥。

衛福部長官 Park Min-Soo 表示：「我們能夠確定非面對面治療的有效性和安全性，能夠消除大醫院對於遠距醫療需求過度集中的擔憂。」「在展開遠距醫療的過程中，病患的選擇權和取得醫療服務的權利，以及醫護人員的專業都獲得尊重。我們有計劃允許使用輔助設備，讓病患和醫護都能安全地使用遠距醫療。」

醫療法修正案

公佈醫療法修正案，實現醫患遠程醫療，提高專業醫療人員短缺地區老年人、殘疾人就醫的可及性，通過慢性病定期管理提高治療效果。

1. 遠距醫療政策至 2013 年

2000 年代韓國出現了隨時隨地提供醫療服務的「泛在醫療」概念，立法宣布修改醫療法允許醫患遠程醫療，允許醫患之間就醫。2010 年，審查允許醫患遠程醫療的法案監管改革委員會對醫療法修正案的內部審查結果擔心醫療濫用和醫療費用快速增加的可能性，在立法過程中暫停。

2. 2013 年起遠程醫療

2013 年，戰略財政部總統商務報告中的遠程醫療推廣報告，貿易投資促進會上重新討論，提及允許遠程醫療，並立法宣布醫療法修訂（提案），韓國醫學會等健康和醫療組織強烈反對集體停工。

2014 年，通過醫療發展委員會宣佈為期 6 個月的遠程醫療試點項目實施結果，並反映在立法中。

2014 年，內閣會議通過了允許醫生與患者進行遠程醫療的《醫療法》修正案，並提交國會。

3. 討論 2014 年遠距醫療試點工作議程

韓國醫學會和政府遠程醫療試點項目的設計，驗證醫療安全和技術安全文件臨床有效性和成本效益的試點項目模型，建議在遠程醫療系統建立到能夠保證技術安全的水平後，進行 6 個月以上的遠距醫療試點以及遠程醫療試點的不可能，政府意見認為遠程醫療應納入遠程醫療試點，短期內 6 個月內見成效，建議分步驟實施遠程監護試點和遠程醫療試點。

參考資料:

<http://tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/report/%5B513%5D19%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%97%AC%E C%8A%A4%EC%BC%80%EC%96%B4%EC%9C%A0%EB%A7%9D%EC%8B%9C%EC%9E%A5%EB%8F%99%ED%96%A5%EB%B0%8F %EC%A7%84%EC%B6%9C%EC%A0%84%EB%9E%B5.pdf>

患者選擇醫生

1. 患者或其監護人可以在綜合醫院、醫院、牙科醫院、韓醫院、療養醫院、精神科醫院選擇特定的醫生、牙醫、韓醫並請求治療。此時，除有特殊理由外，醫療

機構負責人應當根據患者或者患者監護人的請求，安排醫生、牙醫、韓醫等進行治療。<2008.2.29.、2010.1.18.、2018.3.27.、2020.3.4.修改>

2.依第一項規定選擇主治醫生接受治療的患者或其監護人可以要求變更主治醫生。此時，除有正當理由外，醫療機構負責人應當遵照執行。<2018 年 3 月 27 日修訂>

3.醫療機構負責人應當向患者或者患者的監護人提供選擇主治醫生的信息。
<2008.2.29.、2010.1.18.、2018.3.27.修改>

4.醫療機構負責人即使按照第一項規定接受治療，也不得向患者及其監護人收取額外費用。<2018 年 3 月 27 日修訂>

手術室閉路電視設置法醫療法修正案施行日期

收錄自韓網 Blog: <https://blog.naver.com/raincats/223007934210?&isInf=true>
2023.02.07

經過長期爭議後，《手術室閉路電視安裝法》於 2021 年 8 月 31 日獲得國會通過，經過兩年的寬限期後，該法將於 2023 年 9 月 25 日開始實施。據此，各醫療機構必須查閱相關規定並做好相應準備。

安裝目標(根據醫療法第 38 條之 2 第 1 項)

醫療機構的設立者在患者全身麻醉等昏迷狀態下進行手術

並非所有醫療機構都適用，僅適用於在患者昏迷狀態下進行手術的醫療機構，例如全身麻醉。因此，對於在局部麻醉下進行的簡單手術不是強制性的。

所有手術都應該拍攝嗎?(根據醫療法第 38 條之 2 第 2 項)

不！1. 當患者或監護人要求時

2. 醫生要求且患者或監護人同意時

強製手術室閉路電視安裝法並不要求對所有手術進行拍攝。首先，手術室必須安裝閉路電視，但必須在患者或監護人要求的情況下進行拍攝，或者在醫療機構創始人或醫生要求且患者或監護人同意的情況下進行拍攝。

無法錄音(根據醫療法第 38 條之 2③)

但在患者+所有參與手術的醫護人員同意的情況下是可以的

一般來說，即使在拍攝時也不允許錄音。但只有在患者和所有參與手術的醫護人員同意的情況下才能記錄。

遵守(根據醫療法第 38 條之 2 第四項)

制定內部管理計劃、存儲與網絡分離、存儲登錄信息、制定管理相關設施訪客的計劃、確保安全的技術和物理措施

在手術室安裝閉路電視時，必須制定內部管理計劃，並且存儲設備和網絡必須分開。此外，必須準備好技術和物理措施以確保安全，例如保存訪問記錄並制定管理相關設施訪客的計劃。

審閱和提供副本(根據醫療法第 38 條之 2 第 5 項)

1. 相關機構要求時（用於犯罪的偵查、起訴和維護以及法院的審判工作）
2. 醫療糾紛調解仲裁委員會要求時（如果要求並徵得患者同意）
- 3、經患者+全體參與手術的醫護人員同意

如果有關當局（警察、檢察官、法院等）或醫療糾紛調解仲裁委員會出於刑事調查、起訴和維護以及法庭審判的目的提出要求，則無法查看或提供錄製的視頻.並且可以在患者和所有參與手術的醫務人員同意的情況下提供。在解決醫療事故的醫療訴訟中會大量使用。

閱覽及發行費用(根據醫療法第 38 條之 2 第 8 項)

可以向請求觀看的人等提出索賠。

閱讀並發行副本時，可能會向請求者收取費用。

圖片必須保存至少 30 天(根據醫療法第 38 條之 2 第⑨項)

違規制裁(根據醫療法第 63 條)

糾正令

根據修正醫療法第 38 條之 2 的規定，厚生省對各醫療機構安裝閉路電視的費用

進行補貼。根據衛生福利部和公共衛生中心的最新官方文件和指南，每個需要安裝閉路電視的醫療機構都可以通過向公共衛生中心提出申請來獲得支持。具體標準和期限應與當地公共衛生中心確認。

- 설치 기준 단가

(단위: 천원)

수술실 개수	합계	국비(25%)	지방비(25%)	자부담(50%)	비 고
1~2개	4,900	1,225	1,225	2,450	· 카메라, 저장장치, 보안프로그램, 설치비 등 포함 · 의료기관당 단가 한도 내에서 보조비율(자부담 비율) 준수하여 지원
3~4개	10,200	2,550	2,550	5,100	
5~10개	23,000	5,750	5,750	11,500	
11개 이상	38,700	9,675	9,675	19,350	

數據來源：衛生福利部

- 安裝標準單價

(單位：千韓元)

手術室數量	和	政府開支 (25%)	當地費用 (25%)	自費 (50%)	筆記
1-2	4,900	1,225	1,225	2,450	· 攝像頭、存儲設備、安全程序、安裝費 包括 · 各醫療機構單價限額內 符合補貼比例（自費比例）的支持
3-4	10,200	2,550	2,550	5,100	
5至10	23,000	5,750	5,750	11,500	
11+	38,700	9,675	9,675	19,350	

數據來源：衛生福利部

(補貼標準)

老人親和產業支援法(高齡友善產業振興法)

本法的宗旨是，扶持、培育老年友好產業，奠定其發展基礎，為提高老年人生活質量和國民經濟健康發展作出貢獻。

一、「老年友好型產品等」是指以老年人為主要消費對象，且符合下列各項的產品或服務。主要由老年人使用或佩戴的工具、用品或醫療器械。安老服務:主要供老年人使用的住房和其他設施，老年人金融及資產管理服務、老年人信息設備和服務、老年人休閒、旅遊、文化或健康支持服務。適合老年人的農產品或農業支持服務，總統令規定的其他為老年人開發的產品或服務。

二、老年友好產業，是指研究、開發、製造、建造、提供、分銷、銷售老年友好產品等的企業。

三、老年友好型經營者，是指從事老年友好型產業的經營者。

四、「相關中央行政機關」是指負責老年人友好產品等的中央行政機關。戰略財政部、科技信息通信部、文化體育旅遊部、農業食品農村部事務部、產業通商資源部、保健福祉部、僱傭勞動部、國土交通部等。是指總統令規定的中央行政機關。

高齡友善產業發展計劃

一、中央主管機關首長依低生育及高齡化社會基本法第 20 條及第 21 條之規定，制定並實施低出生率及高齡化社會基本計劃及年度實施計劃。生育與老齡化社會應當制定老年友好產業發展規劃（以下簡稱老年友好產業發展規劃）。

二、老年友好產業發展規劃應當包括下列事項：

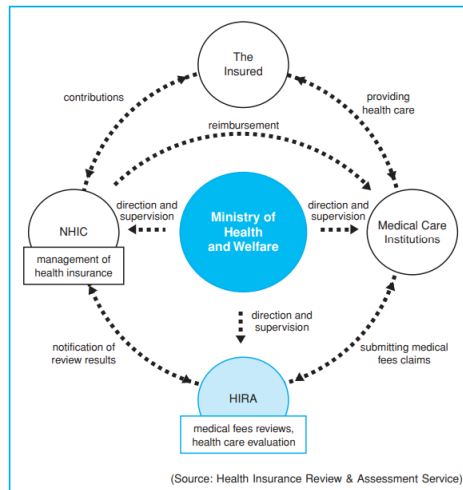
1. 養老產業發展規劃的基本方向
2. 分行業老年友好產業發展政策
3. 奠定老年友好產業基礎
4. 保障和分配用於老年友好產業發展的財政資源
5. 中央老年友好產業相關管理機構的角色分擔
6. 老年友好產業發展所需的其他事項。

醫療保險

醫療保險			
國民健康保險法	醫療援助計畫	長期護理保險計畫	遇到的困難

國民健康保險法

運作方式



大致分為四個部分。一，MIHWAF 負責監督和政策決定，它藉由政策的製定和實施來監督國民健康保險計劃的運作。二，NHIC 負責管理國民健康保險計劃，即參保人員及其家屬的登記、繳費以及設置醫療費用表。三、健康保險審查機構 (HIRA) 負責審核醫療費用和醫療保健評估。接受醫療護理後，患者可以向 HIRA 提交索賠要求審查他的醫療費用，以及 NHIC 可以報銷索賠。

第四，醫療機構提供醫療保健服務。他們受到 MIHWAF 的指導和監督。

***注: MIHWAF 為 Ministry of Health and Welfare**

NHIC 為國民健康保險公司

HIRA 為健康保險審查機構

由來

醫療保健系統最初依靠非營利性保險協會來管理和提供健康保險。從 1977 年到 1989 年，隨著該方案擴大，政府決定允許不同的保險協會為不同的人群提供保險，以儘量減少政府對健康保險系統的干預，這最終導致產生了超過 350 多個不同的健康保險協會。此後，2000 年的重大醫療財政改革將所有醫療組織都合併為國家健康保險局 (NHIS)。在 2004 年，這個新的健康保險集團變成了單一支付醫療服務。該保險制度的資金由繳費、政府補貼和菸草附加費為主，國家健康保險公司是主要的監督機構。

由保健福祉部（韓國）健康保險公司負責通過國家健康保險服務提供醫療保健。韓國人被要求必須通過工資稅向國家健康保險局繳費，為自己及其家屬投保。平均從雇員的月收入中扣除 5% 的工資，由雇員和雇主之間共同承擔。自營職業者必須根據其收入水平通過稅收支付保險費。無力支付國民健康保險費的低收入家庭通過醫療援助計劃獲得健康保險。該計劃由中央政府和地方政府共同出資，由地方政府選擇受益人。

醫療援助計畫

醫療救助計劃成立於 1977 年，頒布《醫療救助法》後，1979 年針對低收入家庭。該計劃中，政府支付無法支付費用的患者的費用衛生保健。2004 年以後，醫療救助計劃擴大覆蓋罕見病、疑難病、慢性病患者以及 18 歲以下的兒童。醫療救助計劃是由中央和地方政府共同資助的。由 MIHWFA 制定並每年修改對於受益人的標準，地方政府再根據條件選擇受益人。近期韓國政府面臨財政困難為低收入人群提供所需的醫療服務存在困難，改變了國民健康保險制度計劃為醫療提供部分資金援助計劃。

長期護理保險計畫

最近韓國的預期壽命大幅上漲，照顧老年人成為家庭的主要負擔，為了解決這個問題，政府推出了長期護理保險計劃在各地多個地點開展國家作為試點實施研究。日常生活活動嚴重受限的老年人有資格申請該計劃。例如，65 歲以上或 65 歲以下的人超過 65 歲但患有與年齡有關的疾病阿爾茨海默病等致殘疾病、帕金森病或中風導致的癱瘓，可以申請該計劃。如果他們符合資格作為受益人，他們可以接受醫療服務，包括洗澡、洗衣和護理。長期護理保險計劃的資金來源長期護理保險繳款受保、政府補貼和由受益人的共同付款。政府資助 20% 的長期護理保險

總額，其基礎是在共同支付系統上。韓國政府希望擴大計劃涵蓋老年人在執行 ADL 方面有不太嚴重的限制。

***注: ADL 為日常生活活動(Activities of Daily Living)**

遇到困難

在韓國醫療地區服務覆蓋的範圍應該得到解決。由於醫療利潤最大化的策略，大多數私人醫療機構位於城市地區，92.1%的醫生和 90.8%的醫院床位位於城市地區，而有 79.7%的人口居住在城市地區。老年人口的增加和衛生財政赤字韓國正在加速進入老齡化社會比任何其他國家。隨著增加老年人口數量有所增加慢性退行性疾病的醫療支出疾病，已成為巨大的社會負擔。韓國政府正在努力通過綜合醫療改革減輕經濟負擔，特別是年輕群體。 MIHWAF 正在採取各種針對老年人的措施，例如擴大醫療保健設施的建設和長期護理保險計劃的推出。

參考資料: https://www.med.or.jp/english/journal/pdf/2009_03/206_209.pdf

韓國國際醫療協會(CKMP)

介紹

韓國國際醫療服務協會是由韓國的專業醫療企業和韓國保健產業振興院和韓國觀光公社組成，兩個政府機關；主要負責向國際社會宣傳韓國醫療服務項目。其主要鎖定韓國重要醫療強項如:體檢、整形外科、牙科、眼科、不孕治療、耳鼻喉科、主要重症疾病及韓方(韓醫院)，目的在於以其高度發展的韓國先進醫療設施和最新醫療技術來提供優質醫療服務，是韓國的醫療觀光的大門。

韓國國際醫學協會的成立是為了鼓勵醫療旅遊。與在美國進行手術相比，如果在韓國接受治療，患者可以節省 30% 到 85%的費用。據報導，由於翻譯和機場接

送等定製服務，一些韓國醫院在對向外國患者收費高於本地患者。因此，一些醫療遊客抱怨這是不公平的。

組成包含：

- 韓國合格醫療照團隊
- 韓國旅遊公社(KTO)
- 韓國保健振興院(KHIDI)
- 韓國健康福祉部(Ministry of Health & Welfare) 贊助

主要職責：

- 執行一系列計劃，將韓國世界級醫療服務推廣至國際社會。
- 推廣活動
- 基礎建設擴展活動
- 改善環境活動

參考資料：https://twcsi.hoeart.com.tw/topic_detail.php?lid=126

推動觀光醫療計畫

韓國政府頒發了七大重點計畫及 13 項一般計畫來推動觀光醫療：

七大重點計畫	
1. 新設外國病患賠償制度：設立醫療糾紛調解院，支援外國患者醫療糾紛。	2. 放寬醫療機構內新建或增建住宿設施之容積率，政府並補助觀光振興基金貸款。
3. 允許在醫院內調劑外國患者藥品（韓國實施醫藥分離制度，此舉可提供外國住院患者 one-stop 服務）。	4. 擴大 Medical Korea Academy 進修課程：在限定範圍內允許外國醫師參與實際診療，並將建設國際醫學研究中心。
5. 擴大培養翻譯、企劃、行銷等醫療專業人才。	6. 加強管理醫療機構之服務設施及基礎建設。
7. 改善外國患者簽證制度。	

13 項計畫

1. 擴大海外觀光醫療推廣機構之業務範圍：允許觀光醫療推廣機構得執行住宿及機票代購等旅遊相關業務。	2. 放寬一般旅行社之觀光醫療推廣機構登錄資格：一般旅行社只要支付外國患者保證保險費（1 億韓元，約新台幣 280 萬元），可登錄為觀光醫療推廣機構。
3. 獎勵優秀觀光醫療推廣機構：每年挑選優秀機構 7 頒發獎牌或獎金等獎勵。	4. 加強海外宣傳：放寬觀光醫療推廣機構之 KOTRA 海外辦事處進駐資格，補助觀光醫療推廣機構參加海外展覽及辦理推廣活動。
5. 加強海外推廣能力：加強蒐集海外市場資訊，加強洽邀海外患者，補助醫療機構拓銷海外市場。	6. 醫療機構名稱英韓併列標示。
7. 新創觀光醫療人才國家資格證書。	8. 提供海外患者方便接送機服務。
9. 降低外國患者機票費用。	10. 管制醫療機構過渡收取外國患者手續費等行為。
11. 加強觀光醫療相關統計系統。	12. 改善觀光醫療政策，管控地區別觀光醫療推廣事業，依地區別執行不同觀光醫療推廣政策。
13. 協助盡早通過自由貿易區域內建立外國醫療機構相關法案。	

參考資料：2012 台灣醫療服務國際化韓國考察團(需下載)

「韓國自 2007 年 3 月起，政府與韓國觀光公社協助 30 多家韓國醫療院所成立韓國國際醫療服務協議會，吸引外國觀光客前往健檢、美容等。」

另採取如下措施：(1)研議解除醫療院所招攬病患限制，使醫療業者合法吸引外國病患赴韓就醫。(2)修訂「醫療債權發行法」，俾利醫療機關募集相關投資資金。(3)放寬醫療機關名稱標示規定，可以用外國語標示。(4)設立綜合醫院病床數標準由現行之 100 床增加至 300 床及受理申請特殊專業健檢醫院等。

為積極推廣國際醫療產業，韓國政府提出「2010 年國際醫療綜合政策」，為了加強其於健康體檢、美容整形、皮膚美容、牙科、韓方等 5 個國際醫療代表的推

廣，在醫療機構的選定、國際醫療商品的持續開發及海外市場行銷等方面給予大力支援。特別是目標海外市場外國人之國際醫療市場，韓國觀光公社透過其全球 27 個據點進行宣傳推廣。首爾韓國觀光公社大樓及仁川機場設立國際醫療宣傳中心，中心裡設有各種先進檢測系統如分析器、壓力測定器、血壓計、皮膚年齡測定器等設備，免費提供前來之旅客使用，並有專家提供詳細解說服務。前來洽詢之旅客可享有休憩的空間，並有藥物保管冰箱、免費上網服務，同時能取得醫療機關和旅遊資訊等。

另外，隨著在韓國生活的外國人數增加，外國人可利用的醫療設施也逐漸增多，在首爾市裡還提供首爾國際醫療中心服務，只要撥打 1339，就可以馬上連結至緊急醫療服務中心，提供外國患者 24 小時的醫療及情報等服務。韓國保健福祉部於 2011 年 3 月頒布「醫療紛爭調節法」，針對受害者於面對醫療紛爭問題出現時，提出所需要的協調紛爭處理程序，並設立韓國醫療紛爭調解仲裁院，主要為協助被害者協助進行協調。大部分醫療訴訟平均需要超過 26 個月才能獲的解決，透過「醫療紛爭調節法」，屆時醫療紛爭案，僅需 120 天內即可以結束醫療紛爭調查及達到協調結果。擬藉此大幅減少外國人來韓赴診之憂慮，吸引更多外國人前來。

異業結盟合作方式

(一)仁川與俄羅斯簽訂促進仁川與俄羅斯簽訂促進與俄羅斯簽訂促進國際醫療合作協定智慧醫療

- 成立國際醫療工作階層的對策工作小組「仁川國際醫療促進團」
- 目的在於推廣國際醫療
- 主要目標對象其中包含俄羅斯、中國、及整個東南亞

(二)韓國保健產業振興願與中國醫療基金會簽訂合作協定韓國保健產業振興願與中國醫療基金會簽訂合作協定保健產業振興願與中國醫療基金會簽訂合作協定

- ✧ 目的在於建立共同合作推廣韓國醫療海外市場
- ✧ 韓國保健產業振興院擬藉用該基金會於中國市場之人脈、及其實體

及虛擬通路管道，以推廣韓國國際醫療。

(三) 韓國仁荷大學醫院與蒙古大使館簽訂同意書

- 成為蒙古大使館的正式醫療服務提供者
- 提供醫療服務與在韓蒙古人
- 蒙古大使館將協助該醫院於蒙古進行義診服務

(四) 韓國 CHA 醫院集團與 SMART INTERNATIONAL SMART INTERNATIONAL SMART INTERNATIONAL 計程車公司簽訂備忘錄

- 享受 ONE-STOP 的高階便利服務
- 該計程車公司提供於仁川機場設有英文/日文服務接待櫃台，讓前來接受醫療服務的國外觀光客們，從下飛機開始到抵達診療中心

參考資料: https://info.taiwantrade.com/EP/resources/member/280178/news/2c9a7248-bb54-4f95-b11a-b74920d0f91b_1304999330204.pdf

醫療紛爭調節法

一般規定

目的在於是為了及時、公正地減輕醫療事故造成的損害，為衛生和醫務人員創造穩定的醫療環境，規定醫療糾紛調解、仲裁的有關事項。非韓國公民向保健醫療機構請求醫療事故損害賠償的，也適用本法。韓國醫療糾紛調解仲裁院根據第六條的規定，應努力確保調解、仲裁程序迅速、公平、高效地進行，參與調解、仲裁程序的爭議雙方應尋求相互的利益。

韓國醫療糾紛調解仲裁院

- ✧ 設立韓國醫療糾紛調解仲裁院（以下簡稱“韓國醫療糾紛調解仲裁院”），以迅速、公平、高效地解決醫療糾紛。
- ✧ 調解仲裁委員會為法人。
- ✧ 調解仲裁委員會根據總統令的規定，可以根據需要設立分支機構。
- ✧ 調解仲裁委員會在其總機構所在地登記成立。

調解仲裁委員會的職責是：

- 1.醫療糾紛調解、仲裁、諮詢
- 2.醫療事故鑑定
- 3.損害賠償
- 4.醫療糾紛相關製度和政策的研究、統計、教育和宣傳
- 5.總統令規定的與醫療糾紛相關的其他職責。

自由貿易經濟區

起源

為了打造韓國新增長引擎的物流、金融等高附加值服務業以及 IT、BT 等高科技產業，打造一流跨國企業東北亞基地的重要戰略，在各國開放和競爭日益加劇的形勢下。為此，2002 年底制定了《經濟自由區的指定和管理法》，2003 年以仁川為起點，在釜山、鎮海、光陽灣指定了經濟自由區。2008 年，李明博政府將大邱、慶北、黃海、新萬金、群山等地區追加指定為經濟自由區。此後，新萬金和群山被從經濟自由區中解除，韓國總共指定並運營了五個經濟自由區。

計劃

此項計畫引進的時間為 2003 年。2003 年指定仁川、釜山 -鎮海、光陽灣等 3 個第一波經濟自由區，在 2008 年又追加指定黃海、大邱-慶北、新萬金群山 3 個等第二波經濟自由區。

1、區域內容：

(1)第一波經濟自由區域(2003 年)：

仁川經濟自由區 (인천경제자유구역, Incheon Free Economic Zone, IFEZ)包括永宗、松島、青蘿三個分區。釜山 -鎮海經濟自由區(부산진해경제자유구역, Busan Jinhae Free Economic Zone, BJFEZ)計有新港灣、鳴旨、智士、頭洞、熊東等五個分區。光陽灣經濟自由區 (광양만권경제자유구역, Gwangyang Bay Free Economic Zone, GFEZ)則包括光陽、栗村、新德、華陽、河東等五個分區。

(2)第二波經濟自由區域(2008 年)：

黃海經濟自由區 (황해경제자유구역, Yellow Sea Free Economic Zone, YESFEZ)由唐津的松岳地區、牙山 的仁州地區及平澤的浦升地區所組成。大邱 - 慶北經濟自由區 (대구경북경제자유구역, Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone, DGFEZ)則包括龜尾數字產業園 5 區、大邱科技城、浦項融合技術與材料產業園區、永川尖端配件與材料產業園區、永川高技術園區、國際文化產業園區、壽城醫療園區、國際服裝設計園區、大邱創新城市地區、慶山知識產業地區等 10 個分區。新萬金 - 群山經濟自由區 (새만금군산경제자유구역 , Saemangeum Gunsan Free Economic Zone, SGFEZ)則由新萬金產業地區、新萬金旅遊地區及古群山國際海洋旅遊地區等 3 個分區構成。

2、推動期間：開發日起約 20 年左右。

3、法律依據：「經濟自由區域之指定及營運相關特別法」(경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법)

4、規劃內容(以仁川經濟自由區為例)

(1)目的：將仁川發展為適合居住與商業活動的城市，松島、永宗、青羅三個區分工互補，成為東北亞的商業樞紐。

(2)參考模仿對象：以新加坡、中國大陸等國作為學習對象。

(3)推動時間：2003 年 8 月開始，預定 2020 年 完成開發。

A、松島地區(國際貿易中心)

技術產業中心、國際物流、商業、知識資通訊產業重鎮。

B、永宗地區(國際航運中心)

國際商業物流及居住園區，擁有世界一流的海岸觀光地、酒店、娛樂城等休閒文化設施。

C、青羅(國際金融中心)

參考連結：<https://www.epza.gov.tw/downloadfile.aspx?fid=b8979f0cab134fb3>

智慧醫療

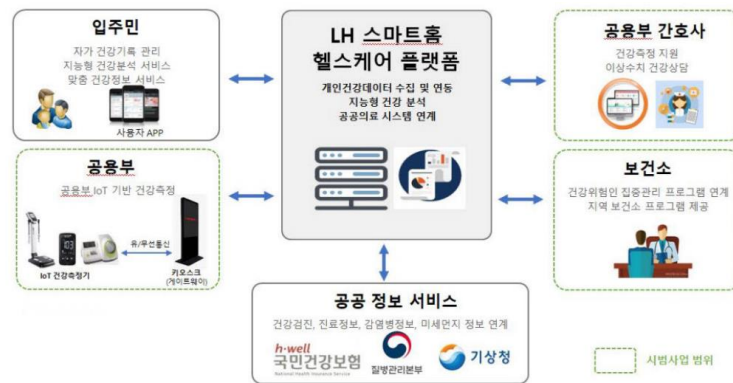
韓國智能家居醫療保健服務

收錄自韓國新聞報導: <https://www.etnews.com/20210929000164>

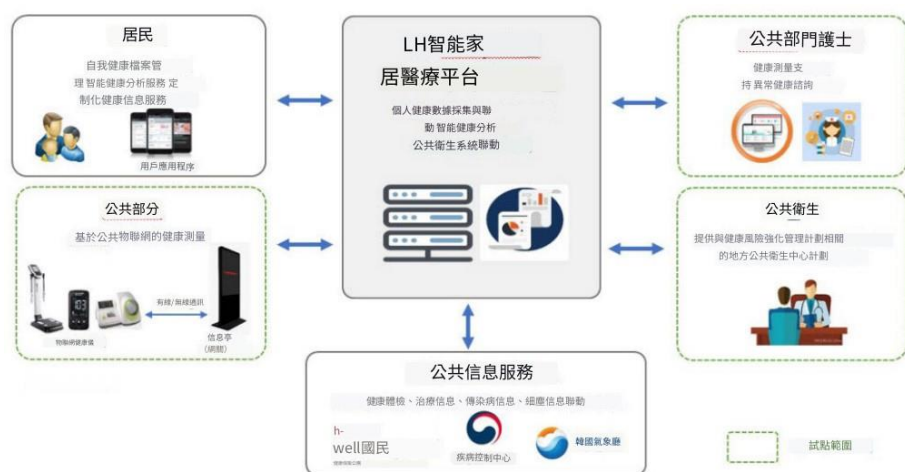
智能家居市場健康保健風正盛這是因為由於 Corona 19 疫情，呆在家裡的時間增加，對醫療保健的需求也隨之增加。與日益增多的醫療保健相關物聯網(IoT)設備聯動並應用標準仍然是一個挑戰。相關行業透露，以建築企業為中心的家電、電信企業，正試圖通過聯手數字醫療企業拓展家庭醫療服務。

在智能家居環境中，醫療保健不僅可以在家中跟隨視頻中的教練進行鍛煉，還可以通過可穿戴設備收集和分析運動數據。它測量血糖和血壓以檢查和預測健康狀況。由於人們對健康的興趣增加以及非面對面醫療服務的擴展，需求正在迅速增加。

韓國土地和住房公司(LH)的“智能家庭醫療保健綜合平台”建設項目就是一個代表性的例子。該平台結合健康保險公司的健康檢查結果、治療和藥物信息以及家中物聯網設備收集的醫療信息，通過移動應用程序(app)提供健康狀況和疾病預測信息。此外，還提供有關居民區傳染病的信息以及與當地公共衛生中心相關的服務。目前，wallpad 公司和數字醫療公司正在開發它。開發將於年底完成，並將在京畿道始興、慶尚南道咸陽等綜合體進行試點運營。



<LH智能家居醫療平台概述>



<LH智能家居醫療平台概述>

數字醫療公司 Huray Positive 也以去年年底完成的國土交通省智能家居醫療平台建設項目為契機，尋求進入該市場。去年，LH 在展廳建立了一個健康預測系統，可與血壓、血糖儀、智能鏡子和體重秤配合使用，目前正在與多家醫療保健物聯網設備公司討論相關項目。

三星物產正在與一家診斷試劑盒公司合作，最早在今年內啟動一項診斷疾病並提供解決方案的服務。通過與專業機構合作，可以使用診斷試劑盒在家中輕鬆識別疾病，並通過移動應用程序、牆墊和智能鏡子提供結果和解決方案。

三星電子、LG 電子和 Coway 等家電製造商也在其旗艦家電中添加了定制的物聯網功能，以管理呼吸系統和皮膚疾病。針對家庭鍛煉需求，還推出了電視、手

機、智能手錶聯動的健康管理服務。

智慧醫療

韓國智慧醫療產業生態現狀

1./公司狀況

智慧醫療行業主要企業分為硬件企業、軟件企業和服務企業。

<國內智慧醫療行業主要企業>

分配	中類	細分	大公司
硬件	<個人健康設備> 用於健康管理的測量健康狀況和生命體徵的（醫療）設備需要獲得食品藥品安全局的批准	血糖儀、血壓計、心電圖、體溫計、尿生化（尿液）分析儀、體成分/體脂肪儀等。	I-Sense、Indavi、The Bio、Infoopia、Jawon Medical、Huvidic、Medical Dream、InBody、Bionics 等
	<健康設備> 戴在身上用於測量和監測生物信號以促進和改善健康的設備	可穿戴終端（智能手環）、血氧飽和度監測儀（運動/休閒）、心率監測儀（運動/休閒）等	三星電子、LG電子、Jikto、Kiwi Plus、Gel Coaster、Smart Sound等
軟件	<通信設備> 用於傳輸個人健康設備和保健設備信息並提供遠程醫療服務的設備	網關、AP、機頂盒、服務器等	H3 System、Sears Technology、Insung Information 等
	<醫療信息化解決方案> 醫療機構醫療信息集成存儲與管理系統	醫療信息平台（EMR、EHR）	Easy Care Tech、UB Care、Bit Computer、Insung Information、Oracle、Life Semantics、Softnet 等
	<個人健康記錄解決方案> 對通過個人健康保健設備獲取的健康信息和醫療信息進行集成存儲和管理的系統	個人健康管理平台（PHR）	Oracle、LifeSemantics、Softnet 等
服務	<健康信息服務> 提供一般醫療信息、運動信息、營養信息等健康信息的服務	健康信息（放鬆方法、營養管理、美容秘訣等）和醫療信息（疾病、藥物等）提供服務、運動利用信息服務等。	MangoApps、YellowToo、BirdView 等
	<個性化健康管理服務> 通過收集個人健康信息，提供定制化健康管理服務	個人健康信息（PHR）管理服務、住院記錄個人信息管理服務、健身/運動管理服務、健康檢查後服務、功能遊戲（康復、癱瘓預防）服務、基因分析服務、遠程諮詢、遠程監護服務等。	Health Connect、Coremed、Noom Korea、Miracom INC、Neofact、Macrogen、DNA Link、Aimed、Openit 等。

資料來源：韓國產業經濟貿易研究院【智能醫療行業的社會經濟效應及政策含義】，2016.11

2./公司分佈及銷售情況

韓國智慧醫療相關企業數量逐年持續增加。智慧醫療相關企業數量 2010 年至 2015 年年均增長率為 5.8%，預計未來將繼續增加。硬件以企業為主，提供診斷或醫療保健等服務的企業數量僅佔總數的 6%左右。2010 年至 2015 年公司總銷售額沒有明顯變化，大部分銷售額由硬件和平台相關公司產生。從銷售額和員工數量來看，國內智慧醫療相關企業嚴重偏向於供應鏈環節，其中以醫療系統軟件

及解決方案等平台（SW-2）開發企業最為活躍。

智慧醫療行業現狀

1./遠距醫療

遠距醫療是指利用視頻通信等信息通信技術向遠方的醫務人員提供醫療知識或技術的遠程醫療。現行醫療法不允許除遠程會診（醫療知識或技術支持）以外的遠程會診或遠距處方，因此也禁止開具遠距處方。對於患者之間的遠程醫療活動，政府打算將醫務人員之間現有的遠距醫療實踐擴展到醫患遠距醫療。

醫療團體反對實施遠程醫療，因為遠程醫療會導致治療和處方不完整，包括誤診，並且地方和地區醫院的治療系統可能會因集中在大醫院而崩潰。健康社會 11 月 20 日，藥劑師協會和藥劑師未來準備會議等民間團體召開新聞發布會，譴責放鬆醫療器械和藥品管制、推廣遠程醫療等醫療保健立法的實施。

遠距醫療海外拓展現狀

- 首爾大學醫院與 SK Telecom 合資成立智能醫療公司，自 2017 年 8 月起在中國醫療機構試點提供糖尿病管理解決方案
- 與全球第三大雲公司阿里巴巴合作，到 2018 年 9 月，基於人工智能的醫學影像系統“DeepFi”將在中國 10 家超大型醫院引入並試點。
- 聯動醫學影像歸檔與傳輸系統（PACS）與人工智能，同時提供醫學影像傳輸與讀取功能
- Aramo-Smart (Aram Huvis)，一家專門從事兒童遠程診斷設備和皮膚/毛髮診斷設備的公司，“Aramo-Smart”將移動功能與皮膚/毛髮影像診斷設備相結合，具有將診斷結果直接傳輸到智能手機或 PC 的功能，讓顧客隨時隨地檢查自己的皮膚狀況，方便診斷和接收相應藥方，最近與中國阿里巴巴合作，鞏固了在中國市場的地位，還有集團等。

KT 和首爾國立大學醫院

韓國電信公司 KT 與首爾國立大學醫院合作開展試點項目，於 2018 年底在西伯

利亞大鐵路上構建移動健康診斷解決方案。

 國內大學醫院、醫療器械行業與中南美洲國家（秘魯、巴西等）、亞洲國家（中國、菲律賓、蒙古等）簽署協議，實現遠程醫療出口成果。

2015 年 4 月，嘉泉吉醫院與秘魯卡耶塔諾埃雷迪亞醫院簽署遠程醫療合作諒解備忘錄。

2015 年 4 月，漢陽大學醫學中心與巴西聖保羅大學醫院簽訂了協議。

2015 年 9 月，首爾聖母醫院與上海龍真醫院簽署了遠程醫療開發協議，延世醫療中心與菲律賓大學系統總醫院於 11 月簽署了遠程醫療開發協議。

2./移動健康

移動健康的定義：法律沒有明確移動健康的定義，但韓國各研究機構的共同定義是「通過使用移動設備（包括智能手機以及專業醫療移動設備）提供健康管理或健康相關信息」，包括連接到個人指導系統等設備的應用程序、通過短信和遠程醫療提供的健康信息和用藥提醒。患者作為醫療服務的消費者，可以通過移動設備和傳感器測量個人健康狀況和日常生活中的生命體徵。通過這種方式，可以增加對自己健康信息的訪問，以便可以快速選擇適當的治療和管理。不僅是現有的醫療器械公司，電信公司和手機製造商也紛紛進入市場，尋求利用智能手機和可穿戴設備進行醫療數據收集和個人健康管理的方法。

3./電子健康記錄與大數據分析

 電子健康檔案（電子病歷 EMR）推廣現狀

2003 年起，通過醫療法的修訂，電子病歷的法律依據和有效性正式確立並啟動。根據醫療法第 23 條（電子病歷），醫務人員或醫療機構創辦人，儘管有第 22 條的規定，仍根據電子簽名法將病歷等轉換為帶有電子簽名的電子文檔（以下簡稱電子病歷）。可以創建和存儲，如果使用電子健康記錄（電子病歷）系統，系統

中存儲的患者的診斷、既往病史、檢查結果等都可以在法定的患者治療範圍內方便醫護人員使用。

韓國國內電子病歷系統中，EMRAM（Electronic Medical Record Adoption Model，衡量醫療機構信息化水平的評價指標）有的醫療機構獲得了世界最高等級 7 級，質量過硬，比如向全球輸出國產醫療信息系統，但大多數醫療機構除了一些三級綜合醫院外，所使用的系統根據投資能力、用戶級別等的不同而有很大差異。儘管電子病歷系統的採用率較高，其在醫療行業發展中的重要性日益增強，但與發達國家相比，韓國仍處於早期階段，還有許多問題有待解決。

智慧醫療行業前景與挑戰

韓國智慧醫療產業競爭力

● 韓國國內醫療保健行業市場

國內智慧醫療行業是一個通過醫療行業價值鏈進行交易、適用醫療法律法規的行業，想要進入智慧醫療領域的企業必須具備進入全球市場的能力和基礎，因為與其他醫療企業一樣，僅韓國國內市場就有明顯的局限性，但有中長期投資的基礎來支撐必須支持。

● 技術和產品競爭力

韓國國內智慧醫療企業注重專利持有能力，知識產權保留率達 70.2%。「個人健康設備」和「個性化健康管理服務」相關專利增加，企業銷售額也增加。通過支持產學研相結合的研發活力和支持初創企業來創建生態系統，以促進行業市場參與和面向領域的核心技術的集約開發，韓國智能醫療研發的行業參與是相當低的。

智慧醫療行業展望

● 激活智慧醫療的系統改進現狀

通過政府試點項目完善保險體系，進行技術創新試驗台和商業模式驗證，並加速

政策制定者的決策。國民健康保險大數據平台設計和模型開發，利用 ICT 為保險公司提供醫療保健服務。個人信息保護法、醫療法、公共機構管理法的修訂。遠程醫療政策的變更。

2013 年 10 月 醫療法修正案，允許醫生和患者之間進行遠程醫療（草案）

參考資料:

<http://tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/report/%5B513%5D19%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%97%AC%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%96%B4%EC%9C%A0%EB%A7%9D%EC%8B%9C%EC%9E%A5%EB%8F%99%ED%96%A5%EB%B0%8F%EC%A7%84%EC%B6%9C%EC%A0%84%EB%9E%B5.pdf>

智慧醫院

「智慧手術室」的建設，減少等待時間，提高滿意度

收錄自韓國新聞: <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230704030800530?input=1>

[195m](#)

2023-07-04

「智慧醫院」是指利用信息和通信技術（ICT）來提高患者安全和醫療質量的醫院。

2022 年，在三個領域推進項目： 智能手術室（忠南大學醫院聯盟）、智能住院環境（首爾大學醫院聯盟、翰林大學東灘聖心醫院聯盟）、患者和監護人教育（延世大學世福蘭斯醫院聯盟）。

忠南大學醫院建造了配備集成控制系統和手術室儀表板的智能手術室，將到達手術室到進入手術室的等待時間從 23 分鐘減少到 21 分鐘，並通過實時信息通過分享手術進展。首爾大學醫院通過手機應用程序進行住院手續後，手術時間從 3 分 29 秒減少到 1 分 23 秒，減少了一半以上，增加了 98%。



圖: <https://blog.naver.com/mohw2016/222485443948>

醫療科技的未來，“智慧醫院”已經走了多遠？

收錄自韓國新聞: <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2194073>

2023.04.03

縱觀衛福部徵集的 2020 年「傳染病應對領先模式」應用案例，「危重患者非面對面協作系統遠程協作」在內科重症監護中得到應用護理單位。

某 47 歲男性在應用體外膜肺氧合（ECMO）裝置時低氧血症加重的情況下，主治醫生採用非面對面協作系統請求通過胸心胸重症監護專家和網絡攝像頭對患者病情進行評估，他獲得了更改當前應用的體外膜氧合裝置的設置值和緊急治療的建議，並將其用於患者護理。

當一名患有高血壓 54 歲的男性進入 COVID-19 自我隔離人員的安全住所並佩戴接觸式溫度計和環形智能戒指時，「使用可穿戴設備進行實時監測」非常有效。在實時監測體溫、脈搏、心電圖的同時，醫護人員在入院第二天就發現發燒 38℃ 以上等異常體徵，並向公共衛生中心通報。

「自動駕駛機器人」被有效地用於運送抗癌藥物和藥品。病房藥房準備的抗癌藥

和麻醉藥品本來要送到抗癌中心和注射室，但送貨負責人因其他緊急任務耽擱了，病人繼續等待。2021 年，在「醫情引領模式」的應用下，「AI 智能防治褥瘡一體化管理」成為可能。此時，自動駕駛機器人安全裝載抗癌藥物和麻醉藥品，並迅速開始配送。

一名 76 歲男性患者發現了壓瘡的危險區域，他在沒有外界幫助的情況下無法改變體位，當發生這種情況時，它會自動請求專業人士的合作。通過智慧醫院系統，還實現了「抗癌藥物不良反應快速響應」。

一名 65 歲女性卵巢癌患者首次化療，化療後 30 分鐘出現呼吸困難、血壓下降，用藥後進行急救。現場還應用了「為所有出院患者自動推薦醫院」系統。

一名 82 歲男性患者因腦出血在大學醫院接受急性治療，決定轉院繼續康復治療。考慮到必要的治療提供功能、患者和監護人的地址以及要求，AI 篩選了適合轉院的醫院給病人。

一位醫療領域的官員表示，「智慧醫院是未來醫院的藍圖，但同時也是已經在應用的現有技術。」與此同時，他表示「當然，並不是所有的醫院和診所都能引進智慧醫院技術，但它可以起到明顯的引水作用，即使不一定是像醫院這樣規模的醫療機構，也可以引入『三級綜合醫院或部分』我們預計是多種選擇，可以減輕人力負擔。」

第四種智慧醫院模式是「智慧用藥、智慧醫護人員培訓、智慧醫院環境」

收錄自韓國新聞: <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2192854>

2023.03.14

隨著領先的智慧醫院模式的第四輪發展，今年的發展模式提出了「智慧用藥安全環境營造」、「醫務人員教育培訓」和「智慧醫院環境」。

智慧醫院是利用信息通信技術（ICT）進行醫療救治，增強患者安全、提高醫療質

量的醫院，通過支持模型開發和示範，醫療機構和相關企業一直在構建和開發智慧醫院的優秀領先模型。今年，在徵求醫療、產業領域專家、學術協會等意見後，從三個方面給予支持：營造安全的就診環境、醫務人員的教育培訓、醫療機構的管理以「為患者創造安全的環境」為主題的智慧醫院環境。

「智慧用藥安全環境營造」將開發用藥安全管理系統、人工智能自動識別和管理帶藥、非面對面用藥指導、建立智能用藥監控系統等模式。通過這種方式，可以利用先進技術實現藥品管理和外賣系統的自動化，通過藥品識別管理重複用藥，通過床邊監視器和移動應用程序提供非面對面的用藥指導，並監控出院患者的用藥情況。之所以提出這一要求，是因為藥劑師、護士等人手不足，導致工作量過大，從藥品倉儲到用藥的整個週期，營造安全的用藥環境的需求增加。

「醫務人員教育培訓」包括手術模擬教育培訓、災情教育培訓、建立區域性虛擬教育中心內容。在實現醫務人員教育培訓模式的同時，利用 3D 視頻和 VR 進行高難度顯微手術模擬培訓、虛擬急救模擬培訓、患者安全事故時的溝通培訓，通過對當地醫護人員的知識和工作表現進行支持區域性虛擬培訓中心等是可能的。由於簡單的觀察和解釋導向的教育以及根據生物倫理學的臨床實踐的局限性，現實的醫學教育和培訓存在局限性。

「智慧醫院環境管理」將推廣智能空調系統、基於 ICT 的環境管理系統、智能噪聲管理、醫療器械管理自動化、建立手衛生監測系統等。例如，可以利用先進技術創建環境管理（溫度、濕度、通風等）監控和工作效率等模型，以及實施基於 AI/RTLS 的手部衛生並建立適當的監控環境。由於醫院環境暴露於各種有害物質和病原體，為患者和工作人員創造安全環境的需求日益增加。另一方面，在評價選擇時，除了三個支持領域外，還包括區域性醫療網絡要素、中小醫院積極參與發展、參與信息溝通等，可加分。基於技術的政府項目，例如 **Medical My Data**。其中，區域醫療網絡要素包括通過區域虛擬教育中心進行臨床實踐、通過在線醫

學教育平台了解當地醫療保健從業人員的知識、工作績效支持以及通過非面對面的患者管理用藥依從性監測。

衛生福利部和促進局對 4 月 5 日前申請的醫療機構（聯合體）項目目標和計劃的可行性、項目執行內容的適當性、項目執行能力和績效管理計劃、擴展計劃進行綜合審查，4 月左右，項目執行機構選擇選定的醫療機構將獲得最高 10 億韓元的補貼（佔自身費用的 50%以上），並將在今年 12 月之前建立領先的智慧醫院模式並示範服務。衛生福利部表示，「醫療機構不限於支持領域描述的例子，而是可以申請符合醫療機構情況和醫療領域需求的各種領先模式。」

韓國政府的“智慧醫院管理模式”的藍圖是什麼？

收錄自韓國新聞: <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2192886>

2023.03.15

厚生省和國立保健福祉研究所在收集意見後宣布，將從三個方面提供支持：以「為患者創造安全的環境」為主題、為患者創造安全的環境、醫護人員教育培訓、智慧醫院環境管理。智慧醫院有希望的醫療機構選擇併申請其中一個領域，並在選定為支持機構時形成領先的模式，並通過具體實例介紹了支持領域。不過，厚生省的前提是「醫療機構不限於支持領域描述的例子，可以申請符合醫療機構需求和醫療機構情況的各種主導模式。」也就是說，可以根據情況自由設計適合各醫院的模型，本次比賽一起介紹的例子與草圖相對應。

在這三個支持領域中，「智慧用藥」旨在利用先進技術為患者創造安全的用藥環境。據醫療機構評價認證研究所統計，患者安全事故中，用藥錯誤（31.9%）佔僅次於跌倒（47.2%）的第二位，且逐年增加。2021 年，由於醫護人員人手不足而超負荷工作，在倉儲、處方配藥、用藥，選擇此領域是因為需要通過效率創建安全的管理環境。針對這一問題，參與醫療機構將開發用藥安全管理系統、人工智能自動識別和管理帶入藥品、非面對面用藥指導、建立出院後智能用藥監控

系統等模式。通過智能用藥模式，衛生福利部「通過引入藥品庫存管理系統，確保藥品採購和管理等合理決策系統，並在配藥、用藥和其他可能發生用藥錯誤的步驟中利用先進技術」。如果發生這種情況，減少醫務人員的工作並提供安全的用藥環境將能夠創造。他透露了預期的效果。他補充說，「將有可能通過自動化來提高工作效率，例如藥物識別任務和重複檢查程序，並通過對患者和監護人的重複用藥指導來提高治療效果。」

此外，還介紹了可應用於每個場景的四個用例。

- 配藥機器人/自動取藥系統：

首先改善了因人力資源、工作環境、組織文化等問題，如藥師短缺、人員素質差等導致安全用藥難的環境。病房內的配藥環境。通過建立配藥機器人和自動輸送系統，可以改善病房的配藥工作負擔和用藥失誤，並減少抗癌藥等特殊藥品配藥過程中因接觸而產生的副作用。

- AI 處方誤差改善：

主治醫生給腦梗塞患者開抗凝血劑時，綜合考慮患者的健康狀況、檢查結果、重疊、合用禁忌等因素開出抗凝血劑，適用於需要安全處方的情況難的。它構建並運營一個系統，應用人工智能等先進技術來適應醫院環境，首先分析錯誤，並在發生錯誤時激活通知等功能，以改善處方錯誤。

- 引入 RFID/條形碼：

雖然在給藥前通過開放式問題和識別標籤匹配來確認患者身份，但它適用於沒有防止患者拒絕或遺漏/錯誤系統的情況。通過引入 RFID 和條形碼進行用藥前確認，建立一個系統，以便為患者量身定制處方，提高 5 對（準確的患者、藥物、劑量、時間、給藥途徑）工作效率和用藥錯誤。

- 出院後的後續護理（地區醫療網絡應用程序）：

即使計劃出院的患者接受了正在服用的藥物的教育，但用藥依從性較低，也可以進行護理。如果出院後仍需要監測，則解釋說，可以通過出院前通過手

機應用程序和智能藥箱進行教育和指導，通過出院後的用藥監測來製定提高治療效果的計劃。

今年智慧醫院項目，從“用藥安全、醫院環境”等三個方面啟動

收錄自韓國新聞: <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2198300>

2023.05.30

今年，「智慧醫院項目」將 ICT、AI 等先進技術應用於醫療，打造新的醫療模式，提供更好的醫療服務，為患者創造安全的環境。藥品管理、醫務人員教育培訓、醫院環境管理三方面宣布啟動。為此，富川世宗醫院聯盟、高麗大學九老醫院聯盟、江東慶熙大學醫院聯盟將開發領先模型。

保健福祉部和健康產業振興院 30 日在首爾韓國酒店舉行了「2023 年智慧醫院領先模式開發支援項目」啟動說明會，並分享了實施機構（三個聯盟）的路線圖。今年，以「為患者創造安全環境」為主題，大賽圍繞三個領域展開角逐：營造安全用藥環境；醫務人員教育培訓；智慧醫院環境管理。選定的聯合體是打造智慧用藥安全環境、醫務人員教育培訓、智能醫院環境管理。

● 打造智能用藥安全環境：

富川世宗醫院為中小型醫院開發基於移動應用程序的智能用藥安全系統，打造用藥安全環境。為此，將開發連接電子病歷系統（以下簡稱 EMR）和醫務人員和患者應用程序的聯合用藥管理數據系統（以下簡稱 CDS），並建立 CDS。該公司計劃通過一款供醫務人員使用的移動應用程序，實現患者服用藥物的識別、處方/配藥和用藥狀態的實時共享、通過藥品包裝上的條碼識別進行藥品信息查詢、以及通過輸液泵自動設置輸液泵。患者特徵。此外，還將開發人工智能模塊，例如基於人工智能的藥丸圖像識別的藥丸識別模塊、處方錯誤檢測和口服處方認證模塊。預計整個用藥週期將通過護士 APP、醫生 APP、患者 APP 等移動化管理，實現全週期用藥的安全管理。

- 醫務人員教育培訓：

通過虛擬空間環境進行更安全的教育培訓內容，以實現臨床領域精準、安全的手術。高麗大學九老醫院構建了多用戶外科教育和培訓 VR 平台，以實施以實際患者案例為中心的教育和培訓系統，在虛擬世界環境的 3D 手術區域中使用實際醫療設備。此外，還計劃建立區域虛擬培訓基地中心，在 AR 培訓環境下進行醫學教育和培訓講座。通過這個平台教育，可以利用 MRI 和 CT 圖像在虛擬環境中像實際患者手術一樣進行模擬手術，並進行討論課。此外，3D 打印可以建模為現實，並可以 1:1 的比例檢查患者的手術部位，從而實現準確、安全的手術，通過這樣的前期準備，微創手術提高了患者的康復速度。

- 智慧醫院環境管理：

主要內容是通過環境管理模式的集成服務，減少醫療廢物，高效管理醫院資源。江東慶熙大學醫院建立了實時歷史管理系統，例如使用機器人收集醫療廢物、基於 RFID 的醫院病房排放物、檢查醫療設備的實時位置以及自動化操作率和頻率設備使用來監控醫療設備的集成狀態。計劃管理。特別是，通過利用 RFID 技術從產生到處置的全過程監控系統，可以對醫療廢物的種類、部門、排放量進行系統化管理，並通過建立實時數據庫進行分析，促進基於證據的 ESG 活動以減少醫療廢物。希望這將成為可能。此外，還可以通過智慧住院護理保障譚妄患者的安全，例如建設智慧譚妄安全病房、通過遠程監控控制譚妄緩解病房的噪音和照明、與當地醫療機構聯合建立譚妄管理系統等。

保健福祉部高級醫療支援官殷成浩表示：「通過智慧醫院項目，我們將為未來醫院提供藍圖，並在需要將先進技術移植到醫療領域的各個領域開發成功模式。我們將支持它，」他說。健康產業發展研究所所長車順道表示，「今年有必要擴大

中小型醫院的參與。」

領先的智慧醫院“首爾聖母醫院”

收錄自韓國新聞: <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2150606>

2021.05.24

加圖立大學首爾聖母醫院被選為保健福祉部「健康醫療數據中心醫院」項目，並建立了研究基礎設施利用大量結構化、非典型的醫療大數據，搶先實現從科研到醫療服務轉變的數字化醫院、智慧醫院。

《醫療時報》會見首爾聖母醫院數字醫療總部負責人金大鎮，聽取智慧醫院領先模式支援項目的現狀及未來目標。目前，首爾聖母醫院正在與恩平聖母醫院以及嘉泉大學醫院合作，利用信息通信技術（ICT）開發：智能感染控制、院內資源管理的領先模型。金大鎮院長表示，首爾聖母醫院參與該項目的原因很簡單。這是因為需要改變整個醫療保健系統，例如由於 Covid-19 而需要非面對面的醫療服務。

金主任說：「在 COVID-19 事件發生後，建立一個能夠識別感染患者和接觸者的活動、保障和保護一線醫務人員的安全、為隔離患者提供心理健康和社會心理支持以及醫務人員，並建立一個能夠整合感染控制的系統的需求正在不斷增長，智慧醫院的概念也已經出現，它將基於物聯網（IoT）的互聯 ICT 技術應用到醫院現場（遠程監控、實時位置跟踪、資產跟踪管理等）。」

- 自主開發流行病學管理-門禁系統：

這裡，「智能門禁系統」是首爾聖母醫院獨立開發的系統，通過將體檢亭與快速門連接起來，最大限度地減少患者/工作人員的接觸。此外，首爾聖母醫院還開發了考慮隔離患者心理穩定性的智能媒體板（SMB），以及對感染患者進行手術的醫務人員可以在沒有感染風險的情況下記錄的“語音 EMR”

手術記錄。此外，為醫務人員心理穩定和關懷而設立的 CMC Mind Talk 服務就是一個代表性的例子。

- 患者 - 十分之八的醫務人員對智能醫院系統持積極態度：

金院長特別強調，該項目不僅對到首爾聖母醫院就診的患者產生了積極的影響，而且對值班的醫務人員也產生了積極的影響。在首爾聖母醫院(參與 317 人)進行的體驗評估中確認，首先，接近十分之八的人表示願意繼續使用智能門禁系統。此外，大約 75% 的人認為鎮紙更有效。同時，超過十分之八的員工表示願意繼續使用資源跟踪管理系統，並對相比現有系統減少工作時間和提高效率表示積極的看法。金主任表示：「就門禁系統而言，患者和醫護人員都感到滿意。」

- 醫院內所有系統集成運行的效率：

首爾聖母醫院還擁有集成的感染控制板，例如電暈病床利用率、PCR 檢測狀態、用於識別確診病例/接觸者的實時定位跟踪系統、以及訪客管理（包括需要篩查治療的人員的狀況）它還建立了「綜合支持管理系統」。此外，該系統通過構建和應用管理狀態（治療績效、患者狀態等）、針對醫務人員的患者特定時間表板以及針對醫療人員的充分性評估狀態板，用於醫院管理者和管理部門的戰略決策。醫療質量管理正在成為現實。金總監的計劃是建立一個更高效的 ERP（企業資源規劃）集成管理系統，同時通過未來升級 nU 板來幫助創建新信息和快速決策。此外，還將支持 EIS（執行信息系統），處理管理者戰略競爭決策、管理和監督所需的信息，並建立故障響應平台，即使在計算機故障的情況下也能確保護理的連續性。

最後，金院長預測，如果建設智慧醫院，就能建立安全的醫療環境，應對持續頻繁的傳染病疫情。金院長表示：「我們將不斷發現與非接觸、非面對面醫療技術相關的新業務，連接 ICT 融合產業。作為醫院，我們將為改善公眾健康和生活質

量做出貢獻。」

與此同時，3 月 1 日，天主教醫療中心成立了「信息融合促進機構」，負責監督 8 個附屬機構的 IT 政策，並任命首爾聖母醫院數字醫療總部負責人金大鎮，擔任推廣院第一任院長。

此外，首爾聖母醫院新成立了「數字健康部」，通過大數據智能醫療研究和臨床融合創造新的醫療服務，以及專門從事非面對面遠程醫療的「智能醫療中心」還新設立了遠程諮詢平台。

智慧醫院總結

智慧醫院是指利用信息通信技術（ICT）進行醫療救治，增強患者安全、提高醫療質量的醫院，通過支持模型開發和示範，醫療機構和相關企業一直在構建和開發智慧醫院的優秀領先模型。智慧醫院是未來醫院的藍圖，但同時也是已經在應用的現有技術。在 2022 年時，分別在三個領域推進項目：智能手術室、智能住院環境、患者和監護人教育；這三個項目減少了不少不必要的時間。今年 2023 年的智慧醫院項目所推動的是：打造智能用藥安全環境、醫務人員教育培訓、智慧醫院環境管理，也是今後未來智慧醫療的藍圖，除此之外也提及了一些用例：配藥機器人/自動取藥系統、AI 處方誤差改善、引入 RFID/條形碼、出院後的後續護理。主要目標讓智慧醫院越來越完善。

台韓比較

健保		
	韓國	台灣
保險對象	1/可區分兩大區分：健保納保人口 (占 96.29%)、低收入戶占	1/納保率達到 99% 2/被保險人分為六類

	(3.71%) 2/被保險人分為職場保險對象者及地區保險對象者 3/救濟欠保險費及滯納金無法繳納之民衆，由缺損處分、分期攤繳來協助	3/救濟欠保險費及滯納金無法繳納之民衆，用分期攤繳、紓困貸款、愛心轉介
財務制度	1/主要財源為保險費收入，每年調整保險費 2/為解決健康保險制財務赤字及財務收支平衡缺口，用菸捐補助金及調整保險費率和健保支付點數值	1/主要財源為保險費收入，僅於2002年調整過一次保險費 2/為解決健康保險制財務赤字及財務收支平衡缺口，用總額預算控制醫療費用之上漲、調整投保金額上限、調整軍公教人員投保金額占全薪比率、調整菸品健康捐之金額、擴大基層門診與各級醫院門診部分負擔之差額等方法克服困境
給付制度	1/住院及慢性洗腎病人等門診者負擔總金額之 20%，自然分娩及未滿 6 歲兒童之住院時免部分負擔，癌症病人等重大傷病之部分負擔為醫療給付費用之 10% 2/於 2005 年 9 月起開始實施“癌症患者登錄制度”結果，癌症醫療費用之部分負擔大幅減少。	1/部分負擔規定區分各層級別及有無經過轉診住院日數，採用不同的部分負擔，而且重大傷病、分娩等免部分負擔。 2/由重大傷病制度，保障防止因病而窮之困境，為重大傷病病人健保投入總醫療支出的 26%

支付制度	1/論服務計酬 2/全面實施 DRG 失敗後，於 2001 年醫事服務機構選擇方式來使用。	1/論服務計酬 2/透過「品質確保方案」的執行，建立醫療服務品質指標 3/實施 53 項目之論病例計酬方式
------	--	---

參考資料: <https://creatrip.com/zh-TW/blog/6638>

<https://www.niusnews.com/=P32wiw13>

<https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gswweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22095NTU05529018%22.&searchmode=basic>

傳統醫學

	韓國	台灣
相同點	1/均實行 TM 與 WM 管理、許可和教育系統分開的雙重製度，TM 系統完善且高度標準化，但與韓國相比，台灣的雙重醫療制度更加靈活，提供了獲得雙重執照的教育課程。 2/都具有保留 TM 的優勢，因為 TM 和 WM 在系統上是獨立的，並且共同提供了更全面的方法。 3/都有類似的 TM 管理體系，包括針灸、拔罐、草藥、手法治療等治療方法。兩個學會擁有專屬的 TM 和 WM 雙醫療追蹤系統。TM 服務和草藥由政府層面控制，並由國家健康保險報銷。	
行政架構	1/管理傳統醫學的行政機構是韓國的韓醫學政策部和衛生福利部 2/兩個部門-TM 政策處-TM 產業處 3/食品藥品安全部(FDA)負責草藥產品的審批和管理。	1/台灣的中醫藥部門和衛生福利部。 2/四個部門-TM 處-TM 藥房處-TM 和藥房許可處-TM 政策制定處，規模比韓醫局還要大 3/中醫藥部門還負責草藥產品的授權和管理

醫療資源及利用	1/TM 醫生數量是 WM 醫生的五分之一 2/門診醫療費用比例:TM 佔治療和檢查費用的 54.3%，草藥僅佔總費用的 1.8%	1/TM 醫生的數量是 WM 醫生數量的七分之一 2/門診醫療費用比例:台灣的 TM 佔 19.4%治療和檢查費用和草藥佔總費用的 33.4%
教育制度 / 教育體系	1/有 12 所大學設有 TM 教員，其中包括一所專門研究生院 2/課程:2 種類型 - 韓醫學研究生院（4 年） - 韓醫學大學（6 年）	1/有 4 所大學的學生人數約為韓國大學的一半 2/ 課程:3 種類型 - 學士學位後中醫系（5 年） - 單科中醫系（7 年） - 中西醫雙學位（8 年） 3/允許學生同時獲得 TM 和 WM 醫生執照
許可證制度	1/擁有雙重執照的 TM 醫生能夠同時在兩個不同的診所執業並提供 TM 和 WM 服務，使他們能夠在兩個醫療執業範圍內提出健康保險索賠 2/TM 醫生在沒有雙重執照的情況下不允許在韓國執業 WM，因此除非擁有雙重執照，否則 WM 醫生沒有資格在韓國執業 TM	1/2008 年以前從醫學院畢業的西醫醫生中，接受過 TM 教育的西醫和雙專業大學畢業的西醫醫生都有資格在台灣參加 TM 執照考試 2/台灣的醫生只能參加一種執業，即 TM 或 WM 臨床執業，並且任一執業的醫生都可以提出保險索賠 3/西醫醫生可以在指定的培訓課程後進行針灸治療，但不能為此提出保險索賠
*注:TM:傳統醫學 WM:西醫		

醫療旅遊		
	韓國	台灣
國際病床數	5% 韓國三級醫院只有 5%的病床能作為國際病床。但在自由經濟貿易區有專屬醫院給外籍人士。	10%
醫病比	平均一位醫師需要照顧 25 床病人	平均一位醫生需要負責 10 床的病人
護病比	平均一位護士需負責 30 床病人	平均一位護士需負責 50 床以下的病人
JCI 認證	33 所(可能有增加)	15 所(可能有增加)
簽證	短期旅遊 C-3-M 簽證：最多 3 個月 長期旅行 G-1-M 簽證：3-6 個月	居留簽證：3-6 個月 停留簽證：6 個月-5 年 延簽 陸籍人士簽證

智慧醫療		
	韓國	台灣
醫療資訊科技進化	1/智慧手術室 2/智慧醫療運送機器人 3/建立綜合支持管理系統	1/智慧手術室使用最廣泛的機械手臂是運用達文西系統，目前廣泛於婦科、泌尿科、一般外科

	4/數字健康部 5/門禁系統 6/智慧醫院 7/智慧家居	隻手術，同時也包刮頭頸、骨科 與腦部手術專用的機械手臂 2/腦部或關節手術，可以以 VR 模型用 3D 的方式讓醫護者了解 問題 3/智慧醫療運送機器人 4/智慧病房、智慧床墊、三階段 離床預警器
電子病例	約 80%獲批進行臨床試驗的研究中心具有電子病歷系統。其餘處於過渡階段。	2013-2016 年推動「台灣健康雲計劃」；2016 年以健康存則行動化

參考資料:

<https://georgeclinical.cn/global-coverage/south-korea-cro/>

https://www.twna.org.tw/WebUploadFiles/PubMagFiles/Article/TWNA_BACKEND/upload/web/ePublication/8067/JNv64n4-026-033.pdf

人口與院所分布

	韓國	台灣
資源最多	最多的前三城市 1.首爾 2.釜山 3.仁川	最多的前三城市 1.台北市 2.嘉義市 3.花蓮縣
資源最少	華城市、安山市、水原市、原州、 晉州市、九里市、和順郡、梁山、 軍浦、金浦、城南市、議政府市、 江陵市	最少的前三城市 1.金門縣 2.新竹縣 3.苗栗縣

問題	醫院大多聚集在城中地區，許多人需要從家裡到城中才能就醫	大型院所大多集中在都市地區，縣市內部也出現了分布不均的情況。以花蓮為例，醫療院所幾乎都分布在花蓮市區，花蓮南部的民眾就醫就極為不便反觀台北市，醫療院所分布密度高，民眾就醫時間和偏鄉形成極大差距
----	-----------------------------	--

參考資料: <https://www.taiwanstat.com/statistics/medical-resources/>

醫院分級		
	韓國	台灣
分級	一級：當地診所 二級：醫院、綜合醫院 三級：整體護理的綜合醫院	醫學中心： 具有研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療等多種功能外，還負有輔導、協助區域內其他醫療機構的責任，並且需通過設有醫學中心數量限制的醫院評鑑 區域醫院： 應具教學醫院功能，建立健全住院醫生訓練制度，並培育專科醫生和地區醫院所需人力。 地區醫院： 提供一般專科門診及住院服務。急性一般病床需 20 床以上，且

		急性一般病床與急性精神病床合計 99 床（含）以下。 醫院： 未經評鑑之醫院 診所
--	--	---

醫藥分業

	韓國(單軌制)	台灣(雙軌制)
規定	一、 藥師法定調劑權 二、 明訂何種情況無處方箋藥師仍可調劑 三、 明訂何種情況醫師可親自調劑 四、 推動處方箋釋出、醫院以治療住院病人為主 五、 禁止醫療機構設置門前藥局條款 六、 明訂經醫師確認可修正處方 七、 對於處方箋釋出的藥品品項，明訂由醫師公會與藥師公會協調各區藥品品項清單	一條軌道是處方箋經由獨立自主的社區藥局藥師所調劑，另一條軌道是處方箋由在醫師掌控下無法獨立自主地發揮專業性判斷功能的藥師所調劑，例如：診所聘僱的藥師或由門前藥局藥師（由醫師出資開設的藥局聘僱的藥師）所調劑的或由偏遠地區開處方的醫師親自兼作調劑的。換言之，是基層醫療診所，既可在醫師看診處 所或門前藥局（在日本稱為第二藥局）聘藥師調劑，也可交付處方箋讓病人選擇持往任一社區藥局去調劑

參考資料: <https://www.taiwan-pharma.org.tw/magazine/119/001.pdf>

台灣加工區、自由貿易經濟區與韓國自由貿易區

	韓國	台灣
開發目的	吸引外國人直接投資、強化國家競爭力及均衡地區發展	為提高國家競爭力及經濟發展之需
開發規模	以創造新市鎮的方式開發，規模相對大	僅在有限範圍內畫定自由區，規模相對小
開發時間	開發時間長達 20~30 年，開發時間非常長	開發期間均以 10 年內完成園區開發
投資獎勵方式	經濟自由區僅提供資本財得免關稅，至營所稅則提供 3 免 2 減半等作法	加工區及自貿港區內使用之機器設備免關稅等
行政管轄權	各行政管轄權分別歸屬相關部會及地方政府	除部分中央或地方行政管轄權(如關務、環保)外，其餘業務均已授權加工區管理處執行

參考連結:<https://www.epza.gov.tw/downloadfile.aspx?fid=b8979f0cab134fb3>

長期照顧

	韓國	台灣
法條	韓國《老人長期照顧保險法》2007 年立法，2008 年實施	長照 1.0 在 96 年核定通過正式啟動，97-100 年為發展基礎服務模式。於 106 年-115 年長期照顧十年計畫 2.0
繳費對象	年滿 20 歲以上投保全民健康保險之被保險人，強制納入長照保險。	稅收
長照財源	1.保費（60-65%）	包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利

	2.稅金補助（20%） 3.自付額（居家服務 15%，機構服務 20%、貧窮弱勢者免除自付額）	捐、捐贈收入、基金孳息收入、其他收入(房地合一稅)及政府預算撥充
給付對象	需同時合乎下列 1.與 2.兩條件，故不包含身心障礙者 1. 65 歲以上出現需要長期照顧之狀況的國民，或是 65 歲以下但是具有老年性疾病而行動不便的國民（例如失智症、中風、與帕金森氏症） 2. 經長照保險等級判定委員會判定須長期照顧（6 個月或以上），且照顧等級為 1 到 3 者（1 到 3 級之外者為所謂「等級外者」，不在長照給付對象之列）。	長照 1.0 服務對象： 65 歲以上失能長者 55 歲以上失能山地原住民 50 歲以上失能身心障礙者 65 歲以上 IADL 獨居者 長照 2.0 新增服務對象： 50 歲以上失智症患者 55 歲以上失能平地原住民 49 歲以下失能身心障礙者 65 歲以上衰弱者
評估者與流程	1. 健保局地方分局會組織一個家訪評估團隊，評估申請者完成日常生活功能[ADL]動作的能力。 2. 由不超過 15 人組成的地方長照資格審查委員會（須包含一名社工與一名醫師），負責就（1）家訪的 ADL 評估報告與（2）醫師所開的報告，綜合裁	照管中心將派專員到府進行訪查與評估，再依據被照護者長照需要等級給予額度

	量申請者資格之准駁與照顧等級判定。	
照顧等級判定	依據五個面向來判定照顧等級：(1) 身體機能(日常生活功能[ADL]13 項)、(2) 認知機能、(3) 行為變化(例如妄想、語言暴力等)、(4) 護理程度(管路)、與(5) 復健程度，分別給分，再按加總分數分成三級。 第一級(極重度)：癱瘓在床無法行動 第二級(重度)：需使用輪椅始能坐立 第三級(中度)：日常生活之飲食、排泄等行為須委由他人照顧、無法單獨外出活動之中度患者	(1) IADLs 復能、ADLs 復能照護：被照護者達到復能或增加獨立活動能力，如使用電話、吃飯、上廁所、走路等。 (2)「個別化服務計畫(ISP)」擬定與執行：依據被照護者需求及期待制定支持服務，培養被照護者於社區中自立生活能力。 (3) 營養照護：依被照護者活動狀況、疾病、體型、體重等，協助被照護者獲取應有之熱量及水份。 (4) 進食與吞嚥照護：協助被照護者安全進食，如指導口腔按摩、調整飲食內容或改變用餐姿勢等。 (5) 困擾行為照護：針對被照護者出現的困擾行為，專業人員指導被照護者和家庭照顧者安全預防概念、溝通技巧與轉移焦慮等。 (6) 臥床或長期活動受限照護：

		協助被照護者維持最基本的活動能力，像是坐起、排泄、進食等，並預防合併症發生。 (7) 居家環境安全或無障礙空間規劃指導： 依據被照護者的需求與身體狀況，提出居家環境改善建議，或進行無障礙空間規劃等。 (8) 居家護理指導與諮詢： 依據被照護者的健康狀況，提供專業的照護指導和諮詢服務，協助家庭照顧者與被照護者自主照護的能力。
給付內容	分為三大類，按失能、失智症程度不同，給付程度亦不同 1. 居家照顧：居家照顧、居家沐浴服務、居家護理、日托與夜托照顧、短期住宿照顧、輔具租借與購買服務等。 2. 機構照顧：長期照顧機構、團體家屋等，標準給付規格為四人房（但限定只有上述第一、二級者可使用）。 3. 現金給付（韓文稱為「家庭療養費」或「家庭照護費」）：符	長照 1.0 服務項目： 照顧服務、居家護理、復健服務、喘息服務、交通接送、輔具服務、營養餐飲、機構服務 長照 2.0 新增服務項目： 失智照顧、原住民社區整合、小規模多機能、照顧者服務據點、社區預防照顧、預防/延緩失能、居家醫療、延伸出院準備、社區三級整合服務

	合以下條件之一之受益者家屬，得申請現金給付（李世代，2009）： （1） 居住在由韓國保健福祉部部長所指定公告之島嶼、偏遠地區等長期照護機構顯著不足地區之居民。 （2） 韓國保健福祉部部長認定因天災地變或類似情況、難以使用長期照護機構所提供的長期照護給付者。 （3） 若有身體、精神及人格特質等以韓國大統領頒訂之事由，需靠家屬來進行長期照護者。	
給付定額與上限 (依 2009 年匯率計算)	等級判定後，服務使用者會得到一個給付定額或服務使用上限。於此範圍內，使用者可自行選擇一個居家或機構服務單位，政府並無指定。 1. 居家照顧： 按照失能程度分三級，每「月」上限，從第三級台幣 20,600 元，到第一級台幣 28,800 元。約為機構照顧每月給付定額的七	等級判定後，會依據分級來決定金額。 1.照顧及專業服務: 依失能等級每月給付 10,200-36,180 元 2.交通接送: 醫師能等級與城鄉差距每月給付 1,680-2,400 元 3. 輔具租借、購買及居家無障礙環境改善:

	成。 2. 機構照顧：按照失能程度分三級，每「日」定額，從第三級台幣 1,044 元，到第一級台幣 1,220 元；或每「月」定額，從第三級台幣 31,500 元，到第一級台幣 37,000 元。 3. 現金給付：不分失能程度，一律每「月」台幣 3,800 元	每三年給付 40,000 元 4. 喘息服務： 依失能等級每月給付 32,340-48,510 元
自付額	1. 居家照顧費用的 15%，機構照顧費用的 20%（機構照顧不包含食物費，且基本給付為四人房，選擇單人房或雙人房者，要自付差額）。 2. 次低所得者（例如因遭逢天災等意外事故致生活困難）得減免 1/2，最低所得者（符合社會救助之最低生活保障者）得全額減免。	1.照顧及專業服務： 一般戶負擔 16%，中低收入戶負擔 5%，低收入戶全額補助 2.交通接送： 一般戶負擔 21-30%，中低收入戶負擔 7-10%，低收入戶全額補助 3.輔具租借、購買及居家無障礙環境改善： 一般戶負擔 30%，中低收入戶負擔 10%，低收入戶全額補助 4.喘息服務： 一般戶負擔 16%，中低收入戶負擔 5%，低收入戶全額補助 ※ 若是家裡有申請外籍看護工，可申請照顧及專業服務(30%額度)、交通接送、輔具與無障礙環

		境評估，而當外籍看護工請假休息時，也可以申請喘息服務。
照顧服務員	1. 資格：韓國人（含歸化取得韓國籍者），不限年齡與學歷 2. 教育訓練課程：總共 240 小時之照顧服務員課程。其內容包含 80 小時理論課、80 小時實作課，80 小時實習。 3. 需通過資格考試（包含韓語考試）	1. 受訓參加「照顧服務員專業訓練課程」取得結業證書 2. 考取「照顧服務員單一級技術士技能檢定」取得照顧服務員技術士證 3. 高中(職)以上學校護理、照顧相關科(組)畢業
服務提供者	營利與非營利團體均可提供居家照顧與機構照顧服務，政府只規範各類服務之規格，不規範服務提供地點與一地之服務密度。	當家中有人需要長期照顧服務時，可先撥打 1966 長照服務專線。1966 長照服務專線提供長照服務申辦，可協助您進一步了解長照服務的服務內容，並依照不同照顧需求提供專業諮詢。

附件

1.台灣長照服務給付表

照顧及專業服務		交通接送		輔具及居家無障礙環境改善服務		喘息服務	
依失能等級 每月給付		依失能等級與城鄉差距 每月給付		每 3 年給付		依失能等級 每月給付	
10,020-36,180 元		1,680-2,400 元		40,000 元		32,340-48,510 元	
一般戶	負擔 16%	一般戶	負擔 21%-30%	一般戶	負擔 30%	一般戶	負擔 16%
中低收入戶	負擔 5%	中低收入戶	負擔 7%-10%	中低收入戶	負擔 10%	中低收入戶	負擔 5%
低收入戶	全額補助	低收入戶	全額補助	低收入戶	全額補助	低收入戶	全額補助

長照服務給付額度表				
長照等級	照顧及專業服務	交通接送	輔具服務與居家無障礙改善 (年)	喘息服務 (年)
第 2 級	10,020元	第一類：1,680元 第二類：1,840元 第三類：2,000元 第四類：2,400元 (根據居住地縣市鄉鎮分類)	40,000元	32,340元
第 3 級	15,460元			
第 4 級	18,580元			
第 5 級	24,100元			
第 6 級	28,070元			
第 7 級	32,090元			
第 8 級	36,180元			48,510元

註：1. 根據經濟狀況（一般戶 / 中低收入）在給付額度內給予不同補助，低收入戶政府全額補助，中低收入戶自付5 ~ 10%，一般戶自付16 ~ 30%。

參考資料:

<http://www.taiwansig.tw/index.php/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%A0%B1%E5%91%8A/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%AE%89%E5%85%A8/6403-%E9%9F%93%E5%9C%8B%E9%95%B7%E7%85%A7%E8%88%87%E5%A4%96%E5%8B%9E>
<https://report.nat.gov.tw/ReportFront/PageSystem/reportFileDownload/C09800643/001>
<https://www.royalnursinghome.com.tw/%E9%95%B7%E7%85%A72-0%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85/>
<https://1966.gov.tw/LTC/cp-6451-69935-207.html>
<https://1966.gov.tw/LTC/cp-6533-70777-207.html>
<https://www.mohw.gov.tw/cp-4253-49404-1.html>

遠距醫療(通訊醫療)法案

	韓國	台灣
法規	1.醫務人員（僅適用於從事醫療業務的醫生、牙醫、韓醫師），雖有第三十三條第一款的規定，但利用計算機、視頻通信等信息通信技術提供醫療服務您可以與遠距離的醫務人員進行支持醫療知識或技術的遠程醫療（以下簡稱“遠程醫療”）。	醫療機構實施通訊診療時，應遵行下列事項： 一、取得通訊診療對象之知情同意。但有急迫情形者，不在此限。 二、醫師應確認病人身分；第二條第二款第一目至第四目情形，不得為初診病人。 三、通訊診療過程，醫師應於醫

	2.想要進行或接受遠程醫療的人員必須配備厚生勞動省條例規定的設施和設備。<2008.2.29、2010.1.18.修改> 3.提供遠程醫療的人員（以下簡稱“遠程醫生”）承擔與面對面治療患者相同的責任。 4.如果根據遠程醫生的遠程醫療進行治療的醫療人員是醫生、牙醫或東方醫生（以下簡稱“本地醫生”），則患者的責任被視為由本地醫生承擔，儘管有第 3 段。	療機構內實施，並確保病人之隱私。 四、依醫療法規定製作病歷，並註明以通訊方式進行診療。 五、護理人員、助產人員或其他醫事人員執行通訊診療醫囑時，將執行紀錄併同病歷保存。 ※不得初診： （一）急性住院病人，依既定之出院準備服務計畫，於出院後三個月內之追蹤治療。 （二）機構住宿式服務類之長期照顧服務機構與醫療機構訂有醫療服務契約，領有該醫療機構醫師開立效期內慢性病連續處方箋之長期照顧服務使用者，因病情需要該醫療機構醫師於效期內診療。 （三）主管機關或其所屬機關有關家庭醫師整合性照護法令規定之病人，因病情需要家庭醫師診療。 （四）主管機關或其所屬機關認可之遠距照護，或居家照護相關法令規定之收案對象，於執行之
--	--	--

		醫療團隊醫師診療後三個月內之追蹤治療。
--	--	---------------------

參考資料:

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=L0020197&kw=%e9%86%ab%e7%99%82%e6%b3%95%e8%a6%8f>

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020197>

<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20230519&lsiSeq=251195#0000>

總結韓國優勢

韓國的醫療系統在國際上擁有非常好的聲譽，也是國際上醫療排名前面的國家，擁有現代化的設施和技術以及優秀的醫療專業人才。韓國擁有新進的醫療技術，該國在癌症治療、器官移植、心臟手術、整形外科等領域具有世界領先的水平。韓國醫療機構也提供了高品質的醫療服務，並注重患者的舒適和安全，並且醫護人員受過嚴格的培訓以確保患者獲得最佳的互利和治療。韓國的醫療機構因為推動觀光醫療計劃，所以吸引了大量的外國患者，尤其是來自亞洲和中東地區。韓國在美容整形領域擁有強大的實力和聲譽，許多人前往韓國進行整型手術，韓國整形外科醫生以高超的技術和美感而聞名。雖然韓國的醫療系統在許多方面相當出色，但仍然可能存在某些挑戰，像是醫療費用或者資源集中在城中地區。

結論

此報告在於探討韓國醫療的體系以及智慧醫療的發展和應用，進而地介紹到韓國健保制度以及台韓比較。韓國醫療以技術和設施聞名，現在韓國以智慧醫院為目標，部分醫院發展了各自的技術，像是富川世宗醫院為中小型醫院開發基於移動應用程序的智能用藥安全系統，打造用藥安全環境；首爾聖母醫院新成立了「數字健康部」，通過大數據智能醫療研究和臨床融合創造新的醫療服務，以及專門從事非面對面遠程醫療的「智能醫療中心」還新設立了遠程諮詢平台，它還擁有

集成的感染控制板，例如電暈病床利用率、PCR 檢測狀態、用於識別確診病例/接觸者的實時定位跟踪系統、以及訪客管理，還建立了「綜合支持管理系統」，「智能門禁系統」是首爾聖母醫院獨立開發的系統。在 2022 年時，部分醫院聯盟建造了智能手術室、智能住院環境、患者和監護人教育。

隨著領先的智慧醫院模式的第四輪發展，今年的發展模式提出了「智慧用藥安全環境營造」、「醫務人員教育培訓」和「智慧醫院環境」，也是韓國智慧醫院未來藍圖。「智慧用藥」旨在利用先進技術為患者創造安全的用藥環境，醫務人員教育培訓以通過虛擬空間環境進行更安全的教育培訓內容，以實現臨床領域精準、安全的手術。「智慧醫院環境」主要內容是通過環境管理模式的集成服務，減少醫療廢物，高效管理醫院資源。

由於韓國旅遊風氣旺盛、醫療技術的領先，實施觀光醫療計劃，吸引了非常多的外國人前往。韓國特別以整形外科、癌症治療、器官移植以及心臟手術聞名，尤其韓國醫療機構提供高品質的醫療服務，包括優秀的醫護人員、便利的就診體驗以及患者安全。且韓國國計醫療協會與多個企業合作，推廣更多國際醫療。

韓國智慧醫療行業主要分為硬件企業、軟件企業和服務企業，韓國智慧醫療相關企業數量逐年增加，以遠距醫療、移動健康、電子健康紀錄與大數據分析做為推廣。

韓國醫療費用一直是一個挑戰，韓國健保每年會討整保險費，其中住院及慢性疾洗腎病人等門診者負擔總 20%，自然分娩及未滿 6 歲的兒童之住院時免部分負擔，癌症病人等重大傷病之部分負擔為醫療給付費用之 10%。被保險人又分為職場保險對象者及地區保險對象者。雖然有健保制度，但實際上僅有 97.1%納保（其餘 2.9%為低收入戶），同時根據資料顯示，韓國人須自付的醫療支出也高達 63.4%，韓國也有 3,500 萬以上的人口需要再自費購入私人保險，以應付緊急醫療時的龐大支出。

韓國醫療可謂全球前幾名的存在，面對台灣的醫療進步，有許多地方是可以借鏡

韓國。以視訊診療為例韓國民眾每人每年就診次數與台灣相近，但在智慧醫療自動化程度相當高，面對數位落差問題，也安排許多志工或是工作人員協助解決，讓民眾從醫院門禁、掛號、候診、繳費領藥都可以在手機上完成。台灣具有許多關鍵優勢，跨界溝通卻不容易，且國內市場規模較小，還有龐大時間成本的挑戰，該如何面對這波優勢，仍要一一擊破高牆，才能進一步創造經濟價值。

參考資料

4 회차 스마트병원 모델은 ‘스마트투약 의료진교육·병원환경’. (2023, 三月 14).

의학신문. <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2192854>

韓國醫療體系—維基百科，自由的百科全書. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日，從

[https://zh.wikipedia.org/zh-](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E4%BD%93%E7%B3)

[tw/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E4%BD%93%E7%B3%BB](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E4%BD%93%E7%B3%BB)

盧碧瑩科技產業資訊室 (iKnow)-. (2019, 四月 29). 南韓 SK Telecom 與延世醫學中心合作 5G 智慧醫院. iKnow 科技產業資訊室.

<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=15531>

台泰韓×比較. (不詳). healthtourism. 讀取於 2023 年 7 月 4 日，從

<https://tracy84she.wixsite.com/healthtourism/industries>

臺灣博碩士論文知識加值系統：自由的博碩士學位論文全文資料庫. 臺灣與韓國健康保險制度之比較. 讀取於 2023 年 7 月 4 日，從 [https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-](https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22095NTU05529018%22.&searchmode=basic)

[bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22095NTU05529018%22.&searchmode=basic](https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22095NTU05529018%22.&searchmode=basic)

許良因. (2021). 韓國醫療改革政策的敘事框架. 人文社會科學研究, 15(2), 81–108.

[https://doi.org/10.6284/NPUSTHSSR.202106_15\(2\).4](https://doi.org/10.6284/NPUSTHSSR.202106_15(2).4)

Creatrip: 韓國健保與台灣的比較. (不詳). Creatrip. 讀取於 2023 年 7 月 4 日，從

<https://creatrip.com/zh-TW/blog/6638>

CSI 台灣服務業聯盟. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日，從

https://twcsi.hoeart.com.tw/topic_detail.php?lid=126

<https://www.facebook.com/niusnews>. (不詳). 全球醫療保健台灣第一、南韓第二！南韓的健保制度人民有比較輕鬆嗎？淺談台韓健保比較 | 生活發現. 紐新聞 niusnews. 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <https://www.niusnews.com/=P32wiw13>

Kim, D., Shih, C.-C., Cheng, H.-C., Kwon, S.-H., Kim, H., & Lim, B. (2021). A comparative study of the traditional medicine systems of South Korea and Taiwan: Focus on administration, education and license. *Integrative Medicine Research*, 10(3), 100685. <https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100685>

Song, Y. J. (2009). *The South Korean Health Care System*. 52(3).

SOUTH KOREA | Summary. (2020, 八月 20). Columbia University Mailman School of Public Health. <https://www.publichealth.columbia.edu/research/others/comparative-health-policy-library/south-korea-summary>

Subscribe to read | *Financial Times*. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <https://www.ft.com/content/b84a4f08-4570-11e4-9b71-00144feabdc0>

건보공단 ‘표준일차의료모델 개발’ 지속 추진. (2023, 四月 6). 의학신문. <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2194557>

「스마트 수술실」 구축하니..."대기시간 줄고 만족도 상승" | 연합뉴스. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230704030800530?input=1195m>

스마트병원 선도하는 ‘서울성모병원’ < 인터뷰 < 병원 < 의원·병원 < 기사본문—의학신문. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2150606>

「스마트홈+헬스케어」 뜬다...표준화 선결 과제—전자신문. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <https://www.etnews.com/20210929000164>

올해 스마트병원 사업, ‘투약안전·병원환경’ 등 3 개 분야 착수 < 복지부 < 정책·행정 < 기사본문—의학신문. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2198300>

우리나라와 비슷하지만 다른 ‘대만 건강보험제도’의 시사점은? - 의학뉴스. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <http://www.newsmpp.com/news/articleView.html?idxno=221761>

의료기술의 미래, ‘스마트병원’ 어디까지 왔나. (2023, 四月 3). 의학신문. <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2194073>

[의료분야 디지털뉴딜, 스마트병원] 지역사회 네트워크 기반의 스마트 감염관리. (不詳). 네이버 블로그 | 보건복지부 공식 블로그. 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <https://blog.naver.com/mohw2016/222485443948>

의학신문—국산 의료기기 개발에 의사가 필요한 까닭? (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 4 日, 從 <https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=135071>

정부의 ‘스마트병원 투약 모델’ 밑그림은? (2023, 三月 15). 의학신문. <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2192886>

劉玟玟.(2012).2012 年台灣醫療服務國際化韓國考察團.行政院經濟建設委員會.

蔡孫碧雲,儲鳳英.(2009).2009 年韓國社會健康保險訓練課程出國報告.中央健康保險局

盧燕嬌 & 陳麗琴. (2017). 智慧醫療與健康照護. 護理雜誌, 64(4).

<https://doi.org/10.6224/JN.000051>

CRO South Korea contract research organization | 乔治临床(George Clinical). (不詳). 乔治

临床(George Clinical) CN. 讀取於 2023 年 7 月 5 日, 從

<https://georgeclinical.cn/global-coverage/south-korea-cro/>

沉民冠記者. (2022, 六月 1). 송승재 라이프시맨틱스 대표 “8 억 건 건강

빅데이터 확보 플랫폼 구축 디지털 치료제·원격진료·마이데이터 추진”.

조선비즈.

<https://biz.chosun.com/industry/company/2022/06/02/46SOVLIP3RCNRLSJNFWUM>

[S3GHQ/](https://biz.chosun.com/industry/company/2022/06/02/46SOVLIP3RCNRLSJNFWUM)

高齡友善產業振興法. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 10 日, 從

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%A0%EB%A0%B9%EC%B9>

[%9C%ED%99%94%EC%82%B0%EC%97%85%EC%A7%84%ED%9D%A5%EB%B2%95](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%A0%EB%A0%B9%EC%B9%9C%ED%99%94%EC%82%B0%EC%97%85%EC%A7%84%ED%9D%A5%EB%B2%95)

韓國長照與外勞 | 台灣新社會智庫全球資訊網. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 7 日,

從

<http://www.taiwansig.tw/index.php/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%A0%B1%E5%91>

[%8A/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%AE%89%E5%85%A8/6403-](http://www.taiwansig.tw/index.php/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%A0%B1%E5%91%8A/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%AE%89%E5%85%A8/6403-)

[%E9%9F%93%E5%9C%8B%E9%95%B7%E7%85%A7%E8%88%87%E5%A4%96%E5%8](#)

[B%9E](#)

李佳勳. (不詳). 用數據看台灣—用圖表呈現台灣醫療資源分配. 用數據看台灣 - 用

圖表呈現台灣醫療資源分配. 讀取於 2023 年 7 月 7 日, 從

<https://www.taiwanstat.com/statistics/medical-resources/>

南韓衛福部呼籲遠距醫療制度化 | 社團法人國家生技醫療產業策進會. (不詳). 社團

法人國家生技醫療產業策進會. 讀取於 2023 年 7 月 10 日, 從

<https://ibmi.taiwan->

[healthcare.org/zh/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhyumw0&REFDOCID](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/zh/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhyumw0&REFDOCID=0rrsov5akxo3816m)

[=0rrsov5akxo3816m](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/zh/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhyumw0&REFDOCID=0rrsov5akxo3816m)

通訊診察治療辦法 條文檢索結果-全國法規資料庫. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 7

日, 從

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=L0020197&kw=%e>

[9%86%ab%e7%99%82%e6%b3%95%e8%a6%8f](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=L0020197&kw=%e9%86%ab%e7%99%82%e6%b3%95%e8%a6%8f)

醫療法. (不詳). 讀取於 2023 年 7 月 7 日, 從

<https://law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9D%98%EB%A3%8C%EB%B2%95/>

醫療事故損害救濟及醫療糾紛調解法 | 國家法律信息中心 | 法規 > 正文. (不詳). 讀

取於 2023 年 7 月 7 日, 從

<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20201008&lsiSeq=217291#0000>

長期照顧司. (2019, 九月 20). 長照基金財源收入無虞 服務資源穩定提升 [文字]. 長

期照顧司; 長期照顧司. <https://www.mohw.gov.tw/cp-4253-49404-1.html>

長期照顧司. (2022a, 六月 9). 照顧服務 [文字]. 長期照顧司; 長期照顧司.

<https://1966.gov.tw/LTC/cp-6451-69935-207.html>

長期照顧司. (2022b, 九月 29). 申請長照服務 [文字]. 長期照顧司; 長期照顧司.

<https://1966.gov.tw/LTC/cp-6533-70777-207.html>

【長照 2.0 懶人包】長照政策好複雜？輕鬆搞懂補助及申請辦法. (2020, 二月 12).

皇家護理集團 | 長照、醫療專業服務.

<https://www.royalnursinghome.com.tw/%e9%95%b7%e7%85%a72->

[0%e6%87%b6%e4%ba%ba%e5%8c%85/](https://www.royalnursinghome.com.tw/%e9%95%b7%e7%85%a72-0%e6%87%b6%e4%ba%ba%e5%8c%85/)

[단독] “반쪽 원격의료법 통과, 대통령이 막아주세요”. (2023, 三月 14). 한국경제.

<https://www.hankyung.com/politics/article/2023031485761>

수술실 CCTV 설치법 의료법 개정안 시행일 주요 내용. (不詳). 네이버 블로그 |

독서 기록실. 讀取於 2023 年 7 月 7 日, 從

<https://blog.naver.com/raincats/223007934210>

의료사회복지사 배치 기준 상향 추진...재정 지원도. (2022, 十二月 22). 청년의사.

<http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3000892>

전국 대학병원 순위 서열. (2022, 七月 7). 경제적 자유를 위해 (0 원에서 1000 억

부자로의 여행). <https://more-money-no-problems.tistory.com/2998>

전국 인구 순위 통계 분포 지도 그래프 보기 (실시간 사이트). (2023, 一月 15).

딩도의 리뷰정보 블로그. <https://dingdo.tistory.com/1676>

<https://more-money-no-problems.tistory.com/2998>

<https://cafe.naver.com/arccommunity/2000?art=ZXh0ZXJuYWwtc2VydmljZS1uYXZlci1zZWZl>

yY2gtY2FmZS1wcg.eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjYXZlIjwZSI6IkdN

BRkVfVVJMIwiY2FmZVVybCI6ImFyY2NvbW11bml0eSI6ImFydGljbGVJZCI6MjAw

MCwiaXNzdWVkQXQiOjE2ODg2MjY1OTk2NjY9.83z5k_1dhaGCoDB3ruIrNZajKfn4

W-0gp9W8MUio4c

<file:///C:/Users/sunny.lee/Downloads/%E5%87%BA%E5%9C%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A>

[%E9%9F%93%E5%9C%8B.pdf](#)

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=571910&cid=46618&categoryId=46618>